

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE FOZ DO
IGUAÇU CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE FRONTEIRA - MESTRADO**

Fabricio Ferreira Delaterra

**Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino
em hospitais de tríplice fronteira**

FOZ DO IGUAÇU

2026

FABRICIO FERREIRA DELATERRA

**Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino
em hospitais de tríplice fronteira**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira - Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito de qualificação para a obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Área de concentração: Saúde Pública em Região de Fronteira

ORIENTADOR: Dra. Luciana Aparecida Fabriz

Foz do Iguaçu

2026

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Delaterra, Fabricio Ferreira

Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de triplice fronteira / Fabricio Ferreira Delaterra; orientadora Dra. Luciana Aparecida Fabríz. -- Foz do Iguaçu, 2026.
81 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu)
-- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, 2026.

1. Saúde do Homem. 2. Política de Saúde. 3. Saúde na Fronteira. I. Fabríz, Dra. Luciana Aparecida, orient. II. Título.

DELATERRA, F. F. **Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de tríplice fronteira**. 2026. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) - Centro de Educação, Letras e Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

Aprovado em: 03 / 03 / 2026

Banca Examinadora

Prof. Dra. Muna Muhammad Odeh

Instituição: UnB – Universidade de Brasília

Julgamento: Aprovado

Documento assinado digitalmente
 MUNA MUHAMMAD ODEH
Data: 07/04/2026 14:37:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dra. Ana Paula Contiero

Instituição: Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Julgamento: Aprovado

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA CONTIERO
Data: 08/04/2026 18:31:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dra. Luciana Aparecida Fabríz

Instituição: Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Julgamento: Aprovado

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA APARECIDA FABRIZ
Data: 10/04/2026 16:14:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEDICATÓRIA

*Dedico este estudo a Deus e a minha família
com carinho e gratidão e a todos os homens
profissionais de enfermagem que se dedicam a
cuidar da saúde dos pacientes e se esquecem
que da sua saúde física e mental depende a
recuperação de seus pacientes.*

AGRADECIMENTO

Agradeço inicialmente a Deus, o Senhor da vida que nos cumula de tantas graças e bênçãos na vida e nos fortalece na luta em busca de melhorar as condições de trabalho e o autocuidado entre profissionais de enfermagem.

Agradeço a minha esposa Bárbara e minhas filhas Laura, Mariana e Isabela, que com carinho e dedicação me apoiam, incentivam e contribuem para que eu busque conhecimentos que possam para tornar o cuidado em saúde mais leve. Estendo o meu agradecimento aos meus pais e familiares que acolhem e incentivam a buscar conhecimento.

Aos meus colegas de curso sou grato pelo companheirismo e por dividir as expectativas de se conquistar melhores ambientes de trabalho na saúde pública de fronteira.

Estendo a minha gratidão aos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que tão prontamente prestaram informações preciosas para concretizar a pesquisa, espero de coração que suas conquistas possam contribuir para melhorar o atendimento em saúde nas fronteiras do mundo.

Aos professores que se dedicaram em dividir saberes, orientar caminhos e saídas para as dificuldades enfrentadas no curso de mestrado e na vida, a minha eterna gratidão, especialmente, à Professora Dr^a Luciana Aparecida Fabriz, que com dedicação e conhecimento orientou a minha pesquisa.

Muito Obrigado!

A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!

Florence Nightingale_

RESUMO

DELATERRA, F. F. **Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de tríplice fronteira**. 2026. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) - Centro de Educação, Letras e Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

A presente pesquisa é voltada para saúde do homem e investiga as percepções dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados preventivos de saúde, considerando que, cotidianamente, estes profissionais realizam a migração pendular na fronteira do Brasil com o Paraguai. O objetivo do estudo foi compreender a percepção, as práticas e as oportunidades para promoção da saúde e prevenção de agravos entre profissionais de enfermagem do sexo masculino, que atua em hospital em município de tríplice fronteira, toma-se como objetivos específicos identificar os hábitos dos profissionais de enfermagem voltados para a sua saúde e qualidade de vida, compreender os fatores motivadores e possíveis dificultadores para a adesão às ações relacionadas à promoção da saúde e prevenção de agravos do homem no contexto de fronteira e verificar as oportunidades oferecidas em ambiente de trabalho voltadas para a saúde preventiva do homem. Quanto ao método, trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi direcionada a 19 (dezenove) enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham no hospital municipal tendo sido selecionados aqueles com vínculo funcional ativo e que atravessam a fronteira para estudar ou que residem no país vizinho, os dados foram coletados por meio de entrevista estruturada e o tratamento dos dados foi realizado por meio de análise descritiva exploratória. Os resultados demonstram que os participantes da pesquisa apresentam intensa jornada de trabalho no hospital somada ao estudo no curso de medicina no Paraguai, o que indica sobrecarga ocupacional e baixa percepção da necessidade de realizar autocuidado preventivo de saúde. Considerando que o ato de cuidar na área de saúde exige comprometimento e dedicação, é preciso que os profissionais demonstrem a percepção do autocuidado para desempenhar suas atividades sem adoecer. Conclui-se que este é um assunto pouco abordado, o que torna necessário realizar novos estudos voltados para estabelecer estratégias técnicas e científicas, que proponham caminhos para fortalecer os serviços de saúde da atenção básica, mobilizando a equipe de enfermagem do trabalho e outros setores que estejam voltados a valorizar e promover a saúde dos profissionais de enfermagem, com campanhas e publicidades, formando grupos masculinos de educação em saúde.

Palavras-chaves: Saúde do Homem; Política de Saúde; Saúde na Fronteira

ABSTRACT

DELATERRA, F. F. **Perceptions of men's health among male nursing professionals in triple border hospitals.** 2025. Dissertation (Master's Degree in Public Health in Border Region) - Center for Education, Literature and Health, State University of Western Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

This research focuses on men's health and investigates the perceptions of nursing professionals regarding preventive health care, considering that these professionals routinely commute across the border between Brazil and Paraguay. The study aimed to understand the perceptions, practices, and opportunities for health promotion and disease prevention among male nursing professionals working in a hospital in a tri-border municipality. Specific objectives included identifying the habits of nursing professionals related to their health and quality of life, understanding the motivating factors and potential obstacles to adherence to actions related to health promotion and disease prevention for men in the border context, and verifying the opportunities offered in the workplace focused on men's preventive health. Regarding the method, this is a descriptive study with a qualitative approach, whose data collection was directed to 19 (nineteen) nurses and nursing technicians working at the municipal hospital. Those with an active employment relationship and who cross the border to study or reside in the neighboring country were selected. Data were collected through structured interviews, and data processing was carried out through exploratory descriptive analysis. The results demonstrate that the research participants have an intense work schedule at the hospital combined with their studies in the medical course in Paraguay, which indicates occupational overload and a low perception of the need to perform preventive self-care. Considering that the act of caring in the health field requires commitment and dedication, it is necessary for professionals to demonstrate an awareness of self-care in order to perform their activities without becoming ill. It is concluded that this is a topic that has been little addressed, which makes it necessary to carry out new studies aimed at establishing technical and scientific strategies that propose ways to strengthen primary health care services, mobilizing the occupational health nursing team and other sectors that are focused on valuing and promoting the health of nursing professionals, with campaigns and advertising, forming men's health education groups.

Keywords: Men's Health; Health Policy; Health on the Border

RESUMEN

DELATERRA, F. F. **Percepciones de la salud de los hombres entre profesionales de enfermería masculinos en hospitales de la triple frontera.** 2025. Tesis (Maestría en Salud Pública en Región de Frontera) - Centro de Educación, Letras y Salud, Universidad Estadual del Oeste de Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

Esta investigación se centra en la salud masculina e investiga las percepciones de los profesionales de enfermería respecto a la atención preventiva, considerando que estos profesionales se desplazan rutinariamente a través de la frontera entre Brasil y Paraguay. El estudio busca comprender las percepciones, prácticas y oportunidades para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades entre los profesionales de enfermería varones que trabajan en un hospital en un municipio de la triple frontera. Los objetivos específicos incluyen identificar los hábitos de los profesionales de enfermería relacionados con su salud y calidad de vida, comprender los factores motivadores y los posibles obstáculos para la adherencia a las acciones relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para los hombres en el contexto fronterizo, y verificar las oportunidades que se ofrecen en el entorno laboral centradas en la salud preventiva de los hombres. En cuanto al método, se trata de un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo, cuya recolección de datos se dirigió a 19 (diecinueve) enfermeros y técnicos de enfermería que trabajan en el hospital municipal. Se seleccionaron aquellos con una relación laboral activa que cruzan la frontera para estudiar o residir en el país vecino. Los datos se recolectaron mediante entrevistas estructuradas y el procesamiento de datos se realizó mediante un análisis descriptivo exploratorio. Los resultados demuestran que los participantes de la investigación tienen una intensa jornada laboral en el hospital, combinada con sus estudios de medicina en Paraguay, lo que indica sobrecarga laboral y una baja percepción de la necesidad de autocuidado preventivo. Considerando que el acto de cuidar en el ámbito de la salud requiere compromiso y dedicación, es necesario que los profesionales demuestren conciencia de autocuidado para realizar sus actividades sin enfermarse. Se concluye que este es un tema poco abordado, lo que hace necesario realizar nuevos estudios orientados a establecer estrategias técnico-científicas que propongan maneras de fortalecer los servicios de atención primaria de salud, movilizando al equipo de enfermería de salud ocupacional y a otros sectores enfocados en la valoración y promoción de la salud de los profesionales de enfermería, mediante campañas y publicidad, y formando grupos de educación para la salud masculina.

Palabras clave: Salud masculina; Política de Salud; Salud en la frontera

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Apresentação da fundamentação teórica dos objetivos propostos.....	27
Quadro 2. Relação da Política de saúde do homem e Qualidade de vida com o questionário de pesquisa.....	28
Quadro 3 – Características sociodemográficas dos profissionais de enfermagem participantes do estudo, Foz do Iguaçu 2024.....	31
Quadro 4. Apresentação das categorias e subcategorias temáticas e sua relação com o referencial teórico.....	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH.....	15
Figura 2. Eixos principais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH.....	17
Figura 3. Eixos conceituais da qualidade de vida.....	22
Figura 4. Síntese esquemática das etapas de coleta de dados da pesquisa.....	24

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

AC	Análise de conteúdo
APS	Atenção primária à saúde
CP	Câncer de próstata
HMPGL	Hospital Municipal Padre Germano Lauck
MS	Ministério da Saúde
OMS	Organização Mundial de Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PNAISH	Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
QV	Qualidade de vida
SUS	Sistema único de saúde
TCLE	Termo de consentimento livre e esclarecido
UBS	Unidade básica de saúde
PNSTT	Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVOS	9
Objetivo Geral.....	9
Objetivos Específicos	9
3. REVISÃO DE LITERATURA.....	10
3.1 A Região de Tríplice Fronteira	10
3.2 A Saúde do Homem	11
3.3 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).....	14
3.4 Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem.....	19
4. PERCURSO METODOLÓGICO	22
4.1 Tipo de estudo.....	22
4.2 População.....	24
4.3 Coleta de dados	24
4.4 Análise dos dados	27
5. ASPECTOS ÉTICOS.....	28
5.1 Riscos.....	29
5.2 Benefícios	29
6. RESULTADOS	30
7. DISCUSSÃO	38
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	49
9. REFERÊNCIAS	53
10. APÊNDICE A – Roteiro de entrevista.....	59
11. ANEXO A – Autorização de pesquisa	65
12. ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	66

1. INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a saúde do homem não contava com políticas específicas, o que contribuiu para que se estabelecesse um conceito de que o ser humano do gênero masculino não precisava desenvolver ações de saúde preventiva. Entretanto, ao estudar os índices de morbimortalidade masculina no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) comprovou que a maioria das mortes entre adultos ocorre com homens, geralmente em decorrência de violência, acidentes e ausência de tratamento preventivo. As áreas médicas como cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia são as mais representativas em enfermidades masculinas e, por isso, são as áreas que mais recebem investimentos financeiros governamentais para desenvolver atendimento preventivo (Brasil, 2022).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a cada dez pessoas que morrem no mundo, sete são homens. Isto se deve ao fato de que, de modo geral, os homens não buscam medidas preventivas de saúde e procuram o serviço de saúde somente quando adoecem, apesar da recomendação para própria OMS para que todos os homens com mais de 40 anos realizem exames preventivos de dois em dois anos (OMS, 2020).

As medidas de prevenção podem ter início mais cedo, quando houver antecedentes familiares, ou seja, predisposição genética. Em caso de homem fumante, sedentário, com sobrepeso, também a rotina de exames deve começar a partir dos 30 anos, com acompanhamento médico (OMS, 2020).

Ademais, estudos epidemiológicos a respeito da saúde do homem têm demonstrado que a expectativa de vida da população masculina é inferior à da população feminina mundial. Em relação ao câncer, por exemplo, dados do Instituto Brasileiro de Câncer apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata (CP) a cada ano, entre 2020 e 2022 (Brasil, 2022).

O Boletim Epidemiológico do MS apresenta que entre 2010 e 2019, foram notificados 143.554 óbitos por câncer de próstata no Brasil, o ano de 2019 foi o período com mais óbitos, correspondendo a 15.983 notificações, e nos anos anteriores de 2018 com 15.576 e 2017 com 15.391, demonstrando que se trata de um número crescente. Com base nesses dados, verifica-se que as políticas de saúde preventiva do homem não vêm sendo eficientes nos cuidados preventivos da saúde do homem, razão pela qual esses números vêm aumentando (BRASIL, 2022).

Nas regiões de fronteira, a saúde masculina é assunto discutido em seminários

internacionais que reúnem profissionais de saúde do Brasil, Paraguai e Argentina, expondo problemas semelhantes. Esses seminários se referem a eventos promovidos com iniciativa da Usina de Itaipu Binacional, das universidades da região e da gestão pública de saúde dos três países, que discutem e buscam soluções conjuntas para questões relacionadas à saúde do homem (Haum; Carvalho, 2021).

De acordo com Mondardo (2020), as transformações históricas e geográficas definem o conceito de fronteira. O antropólogo alemão Fredrik Barth (1998), em seu livro intitulado “Grupos Étnicos e suas fronteiras”, aborda etnograficamente a fronteira buscando entender as dinâmicas de grupo e os interesses envolvidos na identidade da fronteira, buscando compreender como ocorrem as mudanças e quais os elementos que são incorporados a essas concepções.

A questão relacionada à soberania foi incorporada, formal e legalmente nos territórios nacionais ou de Estado, passando a ser compreendida como um espaço delimitado e controlado. Neste aspecto, a fronteira tornou-se um mecanismo fundamental da soberania dos Estados modernos e da organização política das nações. Assim, torna-se fundamental definir que pensar a respeito de uma fronteira, implica em definir os fatores sociais, culturais, políticos e econômicos. Por isso, no ambiente fronteiriço é preciso perceber o espaço social, rico em permeabilidades (Zaslavsky; Goulart, 2017).

Os cidadãos fronteiriços beneficiam-se da mobilidade permitida na fronteira em vários aspectos, tais como: possibilidade de trabalho, acesso a políticas públicas de saúde coletiva e educação, bens e consumo, por exemplo. Os moradores das fronteiras incorporam a fronteira no seu cotidiano, no seu ritmo e nas suas relações sociais e afetivas, concebendo uma sociabilidade típica com consumo coletivo como saúde, educação, saneamento, entre outros. Contudo, quando as cidades fronteiriças não possuem igualdade nas condições de atendimento, a tendência é que haja superlotação e ineficiência nos atendimentos de saúde (Mondardo, 2020).

Em relação aos profissionais de saúde que trabalham na fronteira, verifica-se que há um número elevado de profissionais que trabalham em hospitais, unidade básica de saúde (UBS), clínicas e outros serviços de saúde na cidade de Foz do Iguaçu, ao mesmo tempo em que residem e/ou estudam no Paraguai, onde realizam o curso de Medicina. Essas rotinas exaustivas de trabalho, estudo e descolamento diário tendem a produzir estresse, cansaço, insegurança, entre outras situações que podem contribuir para o desenvolvimento de agravos à saúde desses trabalhadores. (Webber, 2017).

Para Webber (2017), é uma característica feminina estabelecer limites e buscar ajuda quando sente um agravo, o que não se nota nos profissionais homens, que acabam carregando os excessos e só procuram ajuda em necessidade extrema. Ainda, segundo Webber (2017), milhares de estudantes de medicina cruzam a fronteira diariamente para estudar no Paraguai. Entre esses estudantes, muitos são trabalhadores da saúde que atuam em Foz do Iguaçu e que desempenham uma jornada de trabalho exaustiva para realizar o sonho de se formar em medicina.

Zaslavsky e Goulart (2017), ao abordarem sobre a importância e o impacto da migração pendular na busca por serviços de saúde, indicam as peculiaridades da mobilidade humana na região de fronteira. A mobilidade pendular contribui para modificar o espaço urbano, uma vez que apresenta aspectos legais relacionados à área da saúde. Os autores apresentam como exemplo dessa realidade a tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, que caracteriza a migração pendular, especialmente, para uso dos serviços de saúde. Essa mobilidade causa impactos nos serviços de saúde.

A mobilidade pendular exige adequação nos serviços de saúde, pois é um tipo de movimentação peculiar, a distância percorrida entre a residência e o serviço de saúde, o local de residência em um país diferente, bem como as condições de desenvolvimento de atendimento em saúde específicas daquele país, além dos aspectos organizacionais da atenção à saúde, relativa ao atendimento em função da mobilidade internacional. A mobilidade pendular é muito comum na região da fronteira e contribui para a busca por atenção à saúde, especialmente, entre trabalhadores e estudantes, tornando importante analisar se ocorre impacto na saúde das pessoas, para debater a atenção à saúde na região de fronteira (Zaslavsky; Goulart, 2017).

O desenvolvimento de políticas de saúde em região de fronteira requer especificidades adequadas ao atendimento de problemas e questões que são de difícil atendimento, mesmo em outras regiões, mas que se agravam quando relacionadas à mobilidade nas fronteiras internacionais. As políticas de saúde preventiva direcionadas aos homens se tornam, neste caso, um pouco mais difíceis de serem tratadas (Aikes; Rizzotto, 2020).

Sendo assim, é importante reconhecer a percepção dos homens em relação à saúde preventiva no processo saúde-doença, buscando identificar a prevalência de adoecimento e/ou afastamentos deste público em relação às atividades ocupacionais que eventualmente possam ser evitáveis (Schraiber et al., 2011).

Conforme a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT),

em sua portaria 1.823 de agosto de 2012, considerando a relação dessa saúde preventiva e percepção no processo saúde-doença no âmbito ocupacional, traz como diretrizes ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com ações coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos trabalhadores (BRASIL, 2012).

Desta forma, o desenvolvimento de estudos voltados para a concretização das políticas públicas de saúde contribui para que as mesmas sejam divulgadas e que se estabeleçam como prática de incentivo aos exames de prevenção entre os homens.

O problema a ser pesquisado leva em consideração as políticas de saúde do homem que se voltam para o atendimento e a prevenção de doenças, pois se trata de uma camada social que, culturalmente, apresenta resistência à realização de exames preventivos, devido ao descuido e à ausência de conhecimento e de políticas públicas de atenção básica em relação à saúde preventiva do homem (STORINO et al., 2013)

Considera-se que a população masculina não busca realizar exames periódicos de saúde de maneira autônoma por descuido, preconceito ou, simplesmente, por questões culturais. Entretanto, não se percebe a realização consistente de políticas públicas de saúde preventiva que garanta aos homens desenvolver o hábito de buscar exames preventivos, exceto quando são obrigados por relações trabalhistas, isso colabora na promoção para os agravos à saúde masculina (SCHRAIBER et al., 2011).

Doenças crônicas e, muitas vezes, doenças letais poderiam ser evitadas se houvessem políticas públicas efetivas que conduzissem os homens a olhar para si e entender a necessidade de prevenir o surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, câncer de próstata, doenças psíquicas, entre outras patologias que afetam a vida saudável dos homens (SOUSA; SILVA, 2023).

De acordo com Gomes (2007), hábitos como tabagismo, alcoolismo, alimentação, excesso de trabalho e outras características culturais masculinas induzem ao desenvolvimento de doenças e, nestes casos, encontram resistência em assumir a realização de exames de prevenção como uma condição para viver melhor.

Diante do exposto, torna-se relevante conhecer as percepções do homem, profissional de saúde que cotidianamente necessita realizar a migração pendular para um país vizinho, sobre as diretrizes da Política de Saúde do Homem, sua aplicação, as práticas realizadas por ele e as oportunidades que lhe são oferecidas para a promoção da sua saúde e prevenção de agravos. As

informações obtidas podem contribuir na melhoria do bem-estar e elevar os níveis de qualidade de vida desses profissionais, favorecendo autoconhecimento, participação social, preservação de capacidades cognitivas, hábitos saudáveis e/ou redução de ansiedade e depressão.

Em face do problema de pesquisa apresentado, o presente estudo, buscou responder ao seguinte questionamento: Quais as percepções dos profissionais da enfermagem do sexo masculino, que atuam em hospital localizado em região de fronteira e realizam a migração pendular em país vizinho, sobre a sua saúde preventiva?

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Compreender a percepção, as práticas e as oportunidades para promoção da saúde e prevenção de agravos entre profissionais de enfermagem do sexo masculino, que atua em hospital em município de tríplice fronteira.

Objetivos Específicos

- Identificar os hábitos dos profissionais de enfermagem voltados para a sua saúde e qualidade de vida.
- Compreender os fatores motivadores e possíveis dificultadores para a adesão às ações relacionadas à promoção da saúde e prevenção de agravos do homem no contexto de fronteira.
- Verificar as oportunidades oferecidas em ambiente de trabalho voltadas para a saúde preventiva do homem.

3. REVISÃO DE LITERATURA

A construção do conhecimento sobre as políticas de saúde do homem vai além da análise das políticas públicas de promoção em saúde realizadas pelo Ministério da Saúde, visto a importância de conhecer os conceitos históricos e filosóficos que permeiam a saúde do homem, para entender as causas de inúmeros homens não buscarem realizar a prevenção de doenças.

As percepções acerca da saúde, tem sido entendida como interpretações que os sujeitos fazem sobre a sua própria saúde e tem sido importante indicador de como os indivíduos percebem seu bem-estar e compreender sua situação de saúde e autoavaliação (Moura; Gomes; Pereira, 2014).

Assim, este capítulo do estudo foi construído a partir da pesquisa sobre o conceito de tríplice fronteira, do conceito de saúde do homem; da análise das políticas públicas de saúde do homem estabelecidas no Brasil; o desenvolvimento de processos de saúde masculina na epidemiologia brasileira, identificando as implicações dos agravos à saúde do homem na região de fronteira; por fim, descrever e caracterizar o contexto de trabalho dos profissionais de saúde que atuam nos dois maiores hospitais da cidade de Foz do Iguaçu que prestam atendimento SUS, visando o embasamento teórico a respeito da saúde do homem profissional de saúde na fronteira.

3.1 A Região de Tríplice Fronteira

A Tríplice Fronteira é a região de fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, com cerca de meio milhão de habitantes, cujos países se comunicam e têm como línguas oficiais o espanhol e o português, porém outras linguagens circulam na fronteira, especialmente o guarani, considerada como segunda língua do Paraguai, além das linguagens utilizadas pelas cerca de 72 etnias que habitam a região de fronteira. Trata-se da principal fronteira da América do Sul em termos de população, circulação de pessoas e relações internacionais. É considerada uma região internacional compreendida em suas dimensões locais e globais. Atualmente, a região é marcada pela circulação de estudantes que circulam entre os três países em busca de formação (Webber, 2017).

As fronteiras constituem importantes ligações territoriais dos Estados, pelas quais servem como ponto de contato entre duas ou mais unidades políticas e possibilitam interações

espaciais, socioculturais e econômicas (Oliveira-Neto; Garcia; Spinussi, 2020), que decorrem das relações de trabalho, turismo, consumo, transporte de mercadorias e utilização de serviços públicos e privados de saúde e educação (Silva-Sobrinho et al., 2021).

O acesso à saúde, para os residentes fronteiriços, na tríplice fronteira, resumidamente, da seguinte forma: no Brasil, o acesso universal ao Sistema Único de Saúde (SUS) é garantido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”, e pela Lei do Migrante nº 13.445/17, que reforça a aquisição desse direito fundamental para os residentes fronteiriços. Já no Paraguai o acesso à saúde foi trazido pela Constitución de la República de Paraguay, de 1992, e a Lei nº 1.032/96, criou o Sistema de Saúde do país. Os valores básicos assumidos pelo setor de saúde são a universalidade da cobertura, a abrangência de benefícios, igualdade de benefícios, solidariedade e responsabilidade social, porém a lei paraguaia nº 978, de 1996, (Lei Geral de Migrações) avança pouco nas questões de direitos humanos para os migrantes, o que dificulta o acesso dessa população à saúde.

O fluxo de trabalhadores na fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é contínuo na procura dos serviços de saúde pública, sobretudo em direção ao lado brasileiro, devido às assimetrias entre os países e ao acesso universal e integral aos serviços no Brasil (ALUM; BEJARANO, 2011; MARTÍNEZ, 2020). Fatores como mobilidade humana, oferta de atendimento de saúde a estrangeiros e migração pendular são realidades em regiões de fronteiras internacionais em todo Brasil (Fabríz et al., 2021; Ferreira; Mariani; Braticovic, 2015), podendo incidir nas condições de saúde das populações que vivem nesses limites territoriais.

São várias as fronteiras do Brasil, e devido a singularidade de cada uma, como o caso da tríplice fronteira Argentina-Brasil-Paraguai, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas públicas capazes de suprir as necessidades de cada município, a fim de que possam ser assegurados os direitos garantidos aos cidadãos, até porque a região apresenta certas características que requerem um olhar diferenciado para a implementação de políticas locais. (FEITOSA; MARTINS; JAQUEIRA, 2020).

3.2 A Saúde do Homem

O estudo da população masculina em relação à saúde preventiva pode ser realizado no momento do exame periódico nas empresas, pois é um momento que oferece condições de

visualizar o estado de saúde e também por tratar-se de um exame obrigatório, sendo um dos raros momentos que os homens se voltam para cuidar da sua saúde, ainda assim, por imposição do trabalho e em favor da empresa. Além de fundamentais para avaliação do estado de saúde, busca também orientar quanto aos fatores de risco à saúde em que se encontram no momento dos exames. Por meio dos exames periódicos é possível identificar, muitas vezes, e com certa antecedência, alguma condição de saúde alterada, que até mesmo pode ser fator impeditivo para o exercício das atividades laborais (BRASIL, 2022).

Tonelli et al. (2010) analisa um importante aspecto que se apresenta como possibilidade de cuidado à saúde do trabalhador, há que se pensar a partir em duas concepções: a responsabilização dos sujeitos, na opção por hábitos saudáveis, apoiados nas práticas individuais de cuidado; e os modelos que privilegiam a doença, enfatizando os locais de trabalho, que se organizam pela prevenção de doenças e acidentes ocupacionais com intuito de minimizar custos e manter os funcionários em atividade/produção, mas que pouco colaboram para práticas de promoção da saúde preventiva.

É importante considerar que existem determinantes sociais que Cavalcanti et al. (2014) consideram que podem ser responsáveis pela pouca procura de acesso aos serviços de saúde pelos homens, pois considera-se que o homem tem dificuldade em reconhecer suas necessidades voltadas à saúde, encontrando dificuldades em reconhecer suas fragilidades, o que o leva a não considerar a prevenção da saúde como critério predominante em suas vidas pois não percebem o cuidado como uma prática masculina.

Albuquerque et al (2014) pontua que quando se estuda a qualidade de vida dos profissionais de saúde do gênero masculino, percebe-se que há resistência em relação ao autocuidado, entretanto, para que estes profissionais atuem com eficiência é necessário estudar hábitos de vida e cuidados preventivos de saúde. Para Oliveira et al. (2020) é preciso lançar mão de instrumentos que permitam uma avaliação da eficácia, eficiência e impacto de intervenções e serviços que objetivam ajudar os homens que atuam como profissionais de saúde, a permanecerem independentes, autônomos e alertas para o autocuidado.

A legislação brasileira, especialmente a Lei n. 8.080/1990, que estabelece a organização do Sistema Único de Saúde, determina que seja priorizado o atendimento a crianças, mulheres e idosos, porém a legislação omite o atendimento ao homem, indica a necessidade de promover a saúde do trabalhador, mas não especifica as políticas de saúde do homem. Tal fato implica numa questão cultural de rejeição ao atendimento de saúde pelos próprios homens, pois gera

preconceito em relação ao atendimento, porém a saúde de todos os seres humanos é importante, assim surgiram políticas de atendimento preventivo à saúde do homem, além de programas de atendimento de saúde aos trabalhadores (BRASIL, 2009).

Somado às questões políticas, o homem também enfrenta barreiras culturais/estruturais em relação aos cuidados com a saúde, quase sempre os programas priorizam os cuidados com a reprodução e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, no entanto há uma grande incidência de doenças pulmonares e cardiológicas que não são tratadas de modo precoce causando a morte de muitos homens em todo o país (BRASIL, 2022).

As dependências de álcool e de tabaco que também matam milhares de homens e são tratados como desvio de conduta que não encontram respostas em programas que convençam para a necessidade de tratar como doença (GOMES, 2007). Todos estes problemas encontram sérias barreiras e dificuldades de atendimento no sistema de saúde e, na maioria das vezes, acabam em resistência dos próprios homens em procurar ajuda e tratamento, mesmo sabendo que se trata de direito constituído.

Tratamentos crônicos ou de longa duração têm, em geral, menor adesão, visto que os esquemas terapêuticos exigem um grande empenho do paciente que, em algumas circunstâncias, necessita modificar seus hábitos de vida para cumprir seu tratamento. Tal afirmação também é válida para ações de promoção e prevenção à saúde que requer, na maioria das vezes, mudanças comportamentais (BRASIL, 2022).

Segundo Gomes et al. (2007), a população masculina apresenta maior morbimortalidade por doenças que a população feminina e, isto decorre da resistência do homem em procurar os serviços de saúde preventiva. Esta resistência acontece por razões culturais, pois o ser masculino tem necessidade de se mostrar viril, o que justifica a apresentação de dificuldades e a colocação de obstáculos em relação à saúde numa dimensão relacionada ao gênero.

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) as altas taxas de morbimortalidade em homens decorrem do fato de que os mesmos, normalmente, não buscam os serviços de atenção primária voltados à prevenção e promoção à saúde. Em sua maioria, ingressam no sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, quando já se encontram doentes. Essa falta de hábito de monitorar a própria saúde e prevenir o agravamento das morbidades, pode ter como consequência o agravamento das morbidades, aumento nas taxas de mortalidades, incapacidade e absenteísmo laboral, além de maiores custos do tratamento para os indivíduos e/ou para o sistema de saúde.

Há necessidade de se empreender nos meios laborais, educacionais e em outros locais, campanhas educativas a respeito da promoção da saúde preventiva do homem, pois segundo o

Ministério da Saúde a baixa procura pelos serviços de atenção primária faz com que o indivíduo fique privado da proteção necessária à preservação de sua saúde (BRASIL, 2009).

Para Gomes e Nascimento (2006) há que se problematizar as ideias mais recorrentes nas considerações sobre as especificidades do ser homem no processo saúde-doença. Sexualidade masculina, masculinidade/reprodução e masculinidade/ poder, são temas recorrentes nesta questão. Assim, ainda são necessárias investigações sobre a masculinidade relacionada a gênero, nacionalidade, classe, idade, etnia e orientação sexual.

Mendonça e Andrade (2010), por sua vez, consideram que um dos fatores que contribui para a não adesão dos homens às medidas de promoção e prevenção à saúde resulta do estereótipo de masculinidade, decorrente da cultura masculina, que cristaliza valores e crenças sobre o ser homem. A sociedade criou um modelo de masculinidade representado pelo ser forte, não adoecer, recusando qualquer atributo de fraqueza que esteja relacionado ao feminino. Como doença está relacionado à fraqueza e fragilidade, os homens acabam criando uma resistência em tratar preventivamente sua saúde.

Os estudos realizados atualmente apontam para o fato de que ainda há pouca sustentação nas discussões realizadas sobre o assunto. Em termos de lacunas, pode-se destacar que novas pesquisas ainda se fazem necessárias para que sejam aprofundadas as relações entre masculinidade e saúde. As investigações com abordagem qualitativa podem trazer contribuições para que tais relações se tornem mais visíveis a partir dos cenários de nacionalidade, classe, idade, raça/etnia e orientação sexual, dentre outros (BRASIL, 2022).

Separavich e Canesqui (2013) ao abordar a temática da masculinidade, enquanto elemento de discussão das ciências sociais e humanas, pontuam que existem variações no conceito do que seja próprio do homem, o que define a masculinidade uma posição nas relações de gênero que refletem na experiência corporal, na personalidade e na cultura.

3.3 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)

No que diz respeito à saúde do homem, importantes avanços foram implementados a partir de 2009 com a criação da PNAISH, institucionalizada pela “Portaria Nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 e regulamentada pelo Anexo II da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017”. A PNAISH objetiva melhorar a atenção básica à saúde do homem. Nesse sentido, a PNAISH foi estabelecida numa conjuntura que exigia medidas para estimular a população masculina ao autocuidado, reduzir o adoecimento do homem adulto e diminuir os

indicadores de mortalidade masculina (BRASIL, 2009a).

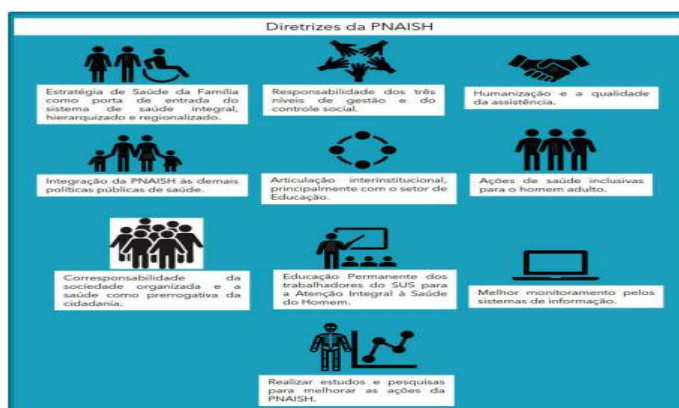
A Portaria nº 1944 de 27 de agosto de 2009 institui a PNAISH no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta portaria, para ser elaborada e sancionada, considerou os altos índices de morbimortalidade da população masculina, os coeficientes de mortalidade masculina em relação aos mesmos da população feminina, a exigência de uma organização da rede de atenção à saúde do homem, a necessidade de motivar à participação dos homens nas ações preventivas e a necessidade de adequar a qualificação dos profissionais de saúde para realizar este atendimento (BRASIL, 2009).

O objetivo da PNAISH é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população. Para tanto, reconhece ser necessário promover uma mudança de paradigmas em relação à percepção da população masculina a respeito de autocuidado com a saúde, não apenas da sua função reprodutiva e de sua sexualidade, mas do ser humano como um todo, educando-se para viver melhor, com mais qualidade e ciência de si mesmo (BRASIL, 2009).

Os principais temas abordados na PNAISH destacam a violência, o alcoolismo e tabagismo, as deficiências, a sexualidade, as doenças respiratórias, cardiovasculares e neoplásicas como as causas mais frequentes de morbimortalidade que necessitam ser tratadas de maneira preventiva (BRASIL, 2010).

As diretrizes da PNAISH (Figura 1) indicaram as linhas de ação e direcionaram a elaboração dos planos, programas, projetos e atividades do setor de saúde, para melhoria do processo de humanização e de qualidade da assistência à saúde.

Figura 1. Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH.



Fonte: adaptado de BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. PNAISH, 2009a.

Há vários estudos que abordam as causas e impedimentos que os homens vivenciam para adotar medidas de prevenção à saúde e qualidade de vida. O SUS ainda divulga pouco os programas e estratégias de saúde voltados para a prevenção do adoecimento para os homens. A ausência de conhecimento e a cultura pouco esclarecida a respeito dos direitos sociais dos homens são determinantes na baixa procura pela prevenção e no agravamento epidemiológico do serviço de saúde em busca de tratamento depois que a doença se agrava.

Um estudo realizado por Aguiar *et al.* (2015) definiu três categorias para analisar a saúde do homem, quais sejam: “Saberes sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem”, “Barreiras e dificuldades para o atendimento integral à saúde dos homens” e, “Atividades realizadas pelos enfermeiros para os homens no atendimento básico de saúde”.

A pesquisa realizada por Aguiar *et al.*, também identificou que existem barreiras como o horário de funcionamento das unidades de saúde, a vergonha ao procurar o serviço, o medo, a ideia de que a unidade de saúde é um espaço para mulheres e a procura por atendimento rápido devido à falta de tempo. Essas atitudes levam os homens a não procurarem atendimento preventivo para melhorar a qualidade de vida e saúde (Aguiar *et al.* 2015).

O estudo desenvolvido por Carneiro *et al.* (2016) destinou-se a compreender a percepção dos profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde - UBS sobre a PNAISH e identificar o conhecimento dos profissionais a respeito da definição, objetivos, princípios, diretrizes, ações, dificuldades e potencialidades para sua implementação. Ficou evidenciado que os profissionais entrevistados não conhecem a PNAISH e poucos compreendem a sua importância para o acompanhamento integral do homem. Assim, as dificuldades para a implementação da PNAISH, não se limita à ausência de recursos materiais e humanos, mas também repercute na falta de interesse do próprio homem em cuidar da sua saúde.

Pesquisadores como Julião e Weigelt (2011) consideram a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH uma ação que se dedica a considerar os agravos à saúde do homem como problemas de saúde pública e, essas ações demandam condutas e medidas preventivas assistenciais específicas.

Para Moura *et al.* (2014), a PNAISH serve para orientar a formulação de estratégias e ações fundamentadas na atenção integral que visam à promoção da saúde e à prevenção de agravos.

Na Figura 2, estão representados os cinco eixos da PNAISH que são o acesso e acolhimento do homem, a saúde sexual e reprodutiva, a paternidade e cuidado, doenças

prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes que garantem o cumprimento de seu objetivo de aumentar a qualidade da saúde da população masculina brasileira (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; BRASIL, 2009a).

Figura 2. Eixos principais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH.



Fonte: adaptado de BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2017; BRASIL, 2009a.

As diretrizes estabelecidas nos eixos da PNAISH apresentados na Figura 2, se referem:

a. Acesso e Acolhimento

Objetiva incluir o homem nos serviços de saúde, de forma que possa familiarizar-se com os espaços de saúde e que ao mesmo tempo seja reconhecido como pessoa que precisa de cuidados.

b. Saúde Sexual e Reprodutiva

Implementar estratégias de reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos do homem adulto por gestores, profissionais de saúde e comunidade.

c. Paternidade e Cuidado

Incentivar gestores, profissionais de saúde e a comunidade no entendimento da importância do homem adulto na participação de todas as etapas da gestação, dos cuidados com os filhos e do fortalecimento dos vínculos familiares.

d. Doenças prevalentes na população masculina

Melhorar o acesso e a qualidade do cuidado à saúde do homem nos serviços de atenção, visando o enfrentamento dos fatores de risco das doenças e agravos à saúde.

e. Prevenção de Violências e Acidentes

Chamar a atenção da população em geral e dos profissionais de saúde sobre a violência urbana, incluindo acidentes que afligem os homens no Brasil.

Um dos aspectos relevantes na PNAISH é o comportamento do homem, nesta perspectiva para Mendonça e Andrade (2010) a saúde do homem surge como uma questão a ser estudada observando o comportamento de risco que os próprios sujeitos do sexo masculino adotam, muitas vezes, pelo conservadorismo arraigado pela masculinidade hegemônica que a sociedade impõe ou por muitos não possuírem hábitos de prevenção.

Santos e Dal Prá (2015) analisaram como a Atenção Primária à Saúde (APS) se organiza para cumprir as diretrizes da PNAISH, visto que desde 1970 discute-se a saúde do homem constituindo-se como relevante, uma vez que as doenças e agravos que afetam a população masculina ampliam os problemas de saúde pública.

Silva et al. (2012) buscaram conhecer e analisar a visão dos enfermeiros que atuavam em UBS sobre o atendimento à saúde do homem e ficou evidente que procuram menos os serviços devido à incompatibilidade de horário com a jornada laboral, além disso, também foi observado a percepção dos sujeitos em sentirem-se constrangidos em procurar atendimento, evidenciando um choque com a cultura androcêntrica. Isto se deve ao fato de que a maioria dos homens desconhece a PNAISH.

Cavalcanti et al. (2014) consideram que é importante conhecer as necessidades de saúde e identificar os obstáculos que impedem o atendimento das necessidades de saúde do homem, assim, é possível apresentar as estratégias de enfrentamento para uma assistência integral e humana aos homens. A população masculina apresenta necessidades de saúde a serem atendidas, porém encontram obstáculos como: a vergonha de se expor, a impaciência, a inexistência de tempo e a falta de resolutividade das necessidades de saúde. Faz-se necessário que ocorra a humanização em saúde em que predomine o enfrentamento, melhoria no acesso, no acolhimento, na comunicação e no vínculo. Isto tudo representa uma preocupação em criar uma PNAISH que contribua para inseri-lo no contexto de saúde, mas é necessário que as mudanças ocorram.

Segundo Carneiro et al. (2019) os homens se acham mais resistentes, fortes e invulneráveis, poucos buscam o atendimento de saúde e declararam que tem como motivação a preferência por se automedicar, falta de tempo e desconforto dentro da UBS.

O conhecimento das necessidades de saúde vivenciadas pelo público masculino e as medidas preventivas que se encontram disponíveis e que os homens desconhecem fazem parte das políticas de saúde do homem criadas no Brasil e desenvolvidas desde 2008 pelo SUS em todo o país. Assim, torna-se fundamental analisar a PNAISH, valorizando as políticas a partir do conhecimento e percepções dos envolvidos.

É importante considerar que as políticas de saúde voltadas ao público masculino devem nortear a busca por melhoria na qualidade do atendimento de saúde, mas também precisam atuar no sentido de motivar e esclarecer os homens sobre a necessidade de buscar cuidados preventivos.

3.4 Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem

A qualidade de vida vem sendo um assunto bastante debatido na sociedade nas últimas décadas, tendo em vista que as pessoas necessitam trabalhar, mas também precisam manter uma boa qualidade na sua alimentação, desfrutar de momentos de lazer, possuir um teto que a proteja, assistência à saúde e à educação, manter uma boa rotina de descanso e cuidar de sua saúde mental e psicossocial. Todas essas perspectivas de viver bem são ignoradas por muitas pessoas e, ainda são insuficientes as políticas públicas voltadas para a manutenção da qualidade de vida das pessoas (Pereira; Teixeira; Santos, 2012).

Um dos fatores de preocupação nos hospitais é o absenteísmo na enfermagem, porém não estão ligadas à negligência e à preguiça, como se costuma pensar, e sim a problemas de saúde, sociais e, em grande parte, a questões relacionadas ao trabalho. O profissional de enfermagem lida com a dor, a morte e o sofrimento do outro e isso tem um reflexo na sua vida.

De acordo com Mattos (2004) membros de equipe de enfermagem, apresentam manifestações físicas e emocionais de desgaste relacionadas ao ambiente de trabalho, as condições mais desgastantes são o excesso de carga horária e problemas de relacionamento interpessoal.

A sobrecarga de trabalho, as relações interpessoais, as situações constantes de dor e morte, a falta de autonomia e o excesso de autoridade dos supervisores no trabalho do enfermeiro suscita discussões. A enfermagem é uma experiência que carrega consigo um grande desgaste. Para Mezzomo (2003) existem aspectos preditores de desgaste relacionados às condições de trabalho desde o período de treinamento profissional. Alguns desgastes se referem à insatisfação quanto à substituição de funcionários nos períodos de folgas, desvio de

função, esgotamento físico e mental, falta de lazer e, principalmente, a conflituosa relação de falta de identidade profissional.

A prevalência de sintomas de depressão entre os profissionais de enfermagem é menor que outros distúrbios como: ansiedade, estresse e a Síndrome de *Burnout* do enfermeiro nas mais diversas áreas de sua atuação. Segundo Mattos (2004) é necessário realizar avaliação desse tipo de problemática direcionada à população de enfermagem, principalmente entre os profissionais do gênero masculino. Avaliar a qualidade de vida e a prevalência de disforia/depressão nos profissionais de enfermagem pode ser a possibilidade de construir um diferencial na qualidade de atendimento na maioria dos hospitais.

Para Batista e Uchôa-Figueiredo (2022) a realização de cuidado em saúde vive uma realidade não resolutive em todo o mundo, o que remete ao desenvolvimento de um cuidado em saúde fragmentado, podendo ocorrer à duplicação de procedimentos, erros na execução e na tomada de decisões no atendimento em saúde, pouca capacidade resolutive e altos custos, além da falta de preparo dos profissionais de saúde para trabalharem juntos, por terem sido formados separadamente, o que indica a necessidade de formação e atualização continuada de recursos humanos para o trabalho em saúde.

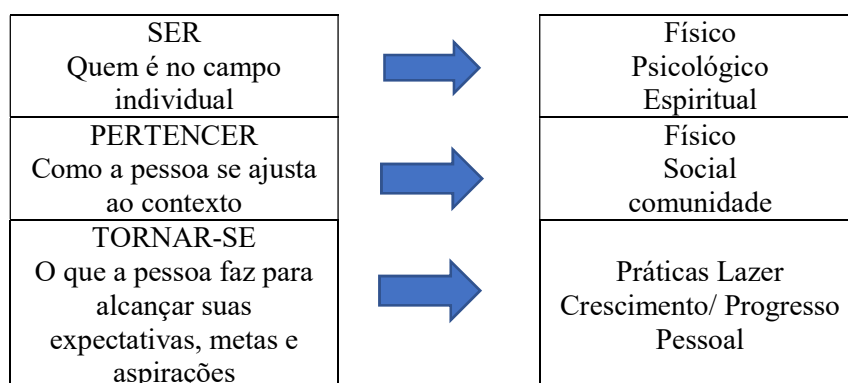
Albuquerque et al. (2014) comenta que o enfermeiro brasileiro tem que enfrentar problemas relativos aos complexos fenômenos de saúde da clientela associados à necessidade de redução dos custos com a prestação dos serviços, sem prejuízo da qualidade. Há que se desenvolver o discernimento de aplicar técnicas e soluções desenvolvidas em outros países e, principalmente, estudar as soluções encontradas no Brasil para a realização das melhores práticas.

A preocupação com questões relacionadas à qualidade de vida aumenta entre os profissionais de enfermagem. A qualidade de vida tem origem no movimento das ciências humanas e biológicas busca valorizar os parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida (Borges; Seidl, 2014). Desta forma, aborda-se a qualidade de vida por diferentes autores, indicando a qualidade de vida como sinônimo de saúde. Há quem analise esse conceito de maneira mais abrangente, considerando esse conceito abrangente, e as condições de saúde fazem parte dos aspectos a serem considerados. Diferentes aspectos que definem a qualidade de vida são apresentados na literatura, como por exemplo, poder aproveitar as possibilidades da vida, de escolher, de decidir e ter controle de sua vida (Pereira et al., 2012).

Neste aspecto, apresentam-se eixos conceituais que permitem compreender as dimensões humanas do ser, pertencer e tornar-se. A dimensão do “ser” é entendida como o que o ser humano é, resultado de sua nutrição, aptidão física, habilidades individuais, inteligência, valores, experiências de vida etc. Quanto ao “pertencer” trata-se das ligações que a pessoa tem em seu meio, casa, trabalho, comunidade, possibilidade de escolha pessoal de privacidade, assim como da participação de grupos, inclusão em programas recreativos, serviços sociais etc. O “tornar-se” remete à prática de atividades como trabalho voluntário, programas educacionais, participação em atividades relaxantes, oportunidade de desenvolvimento das habilidades em estudos formais e não formais, dentre outros. Esses componentes apresentam uma organização dinâmica entre si, consideram tanto a pessoa, como o ambiente, assim como as oportunidades e os obstáculos (Albuquerque et al., 2014).

Diante disso, os eixos da qualidade de vida devem ser investigados como estes se inserem na vida das pessoas. A Figura 3 apresenta a síntese dos eixos de qualidade de vida, conforme (Borges; Seidl, 2014).

Figura 3. Eixos conceituais da qualidade de vida



Fonte: Borges e Seidel, 2014

Assim, a qualidade de vida depende do autoconhecimento, da interação social e ambiental de cada sujeito e das expectativas de vida que cada pessoa tem. Para definir como um grupo social e de trabalho, como os enfermeiros do gênero masculino que atuam em hospital de tríplex fronteira buscam pela qualidade de vida saudável, desenvolve-se, nesta pesquisa uma metodologia de pesquisa que será descrita no capítulo a seguir.

4. PERCURSO METODOLÓGICO

No presente capítulo apresenta-se o percurso metodológico para alcance dos objetivos propostos, Andrade (2009) apresenta a metodologia como o conjunto de métodos que encaminham a busca do conhecimento, por meio de pesquisa.

Segundo Marconi e Lakatos (2017) o conjunto de atividades ordenadas e racionais que, com economia e segurança contribuem para alcançar o objetivo, é denominado método científico, e contribui para identificar os conhecimentos válidos pela ciência, que contribuem para a projeção das metas a serem alcançadas, identificar os caminhos e recursos a serem utilizados, verificar e corrigir os erros e auxiliar nas decisões do pesquisador.

De acordo com Creswell e Clark (2013), as pesquisas envolvem conhecimentos, o uso de métodos, técnicas e procedimentos científicos. Uma pesquisa necessita ser desenvolvida com a organização de um processo em sequência, de forma a permitir a análise desde a identificação do problema a ser solucionado até a apresentação dos resultados.

Demo (2011) pontua que a metodologia descreve como se realiza a pesquisa, demonstra e orienta os processos e situa uma prática profissional. O pesquisador observa, aprende, seleciona e realiza coletas de dados que o auxiliem na identificação da melhor escolha de métodos e técnicas para explorar a temática investigada. Por isso, o método é caracterizado como o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que aferem segurança e economia, para alcançar os objetivos e conhecimentos compromissados com a verdade, são ações que traçam um caminho a ser seguido, detectando erros e ajudando a tomar decisões.

Marconi e Lakatos (2017) indicam que o método adequado para apresentar as características de um fenômeno é a pesquisa descritiva. Assim, para conhecer e interpretar os fenômenos relativos à saúde do homem realiza-se uma pesquisa descritiva para classificar e interpretar este segmento dos estudos.

Esse marco metodológico da pesquisa define os encaminhamentos a serem dados para realizar o estudo. Assim, neste capítulo define-se o tipo de abordagem, a natureza, os procedimentos de coleta e análises de dados.

4.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. As abordagens

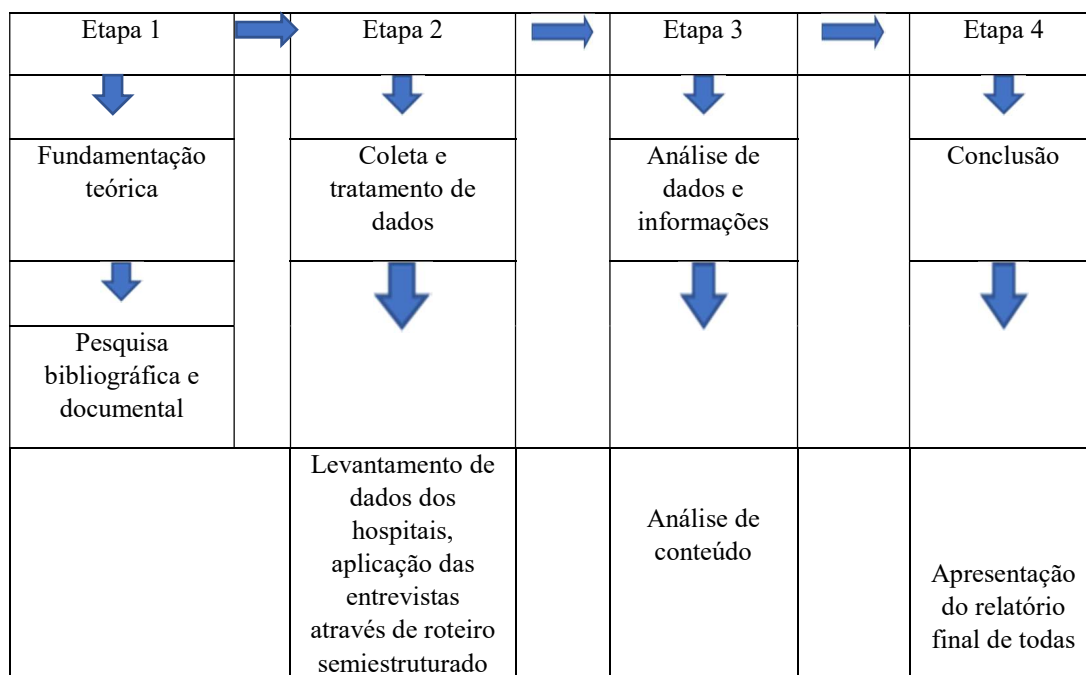
qualitativas obtêm dados descritivos mediante contato direto e interação entre o pesquisador e o objeto de estudo, neste tipo de pesquisas, é frequente que o pesquisador compreenda os fenômenos em acordo com a perspectiva dos investigados, para interpretar os diferentes aspectos do estudo (VASCONCELOS, 2009).

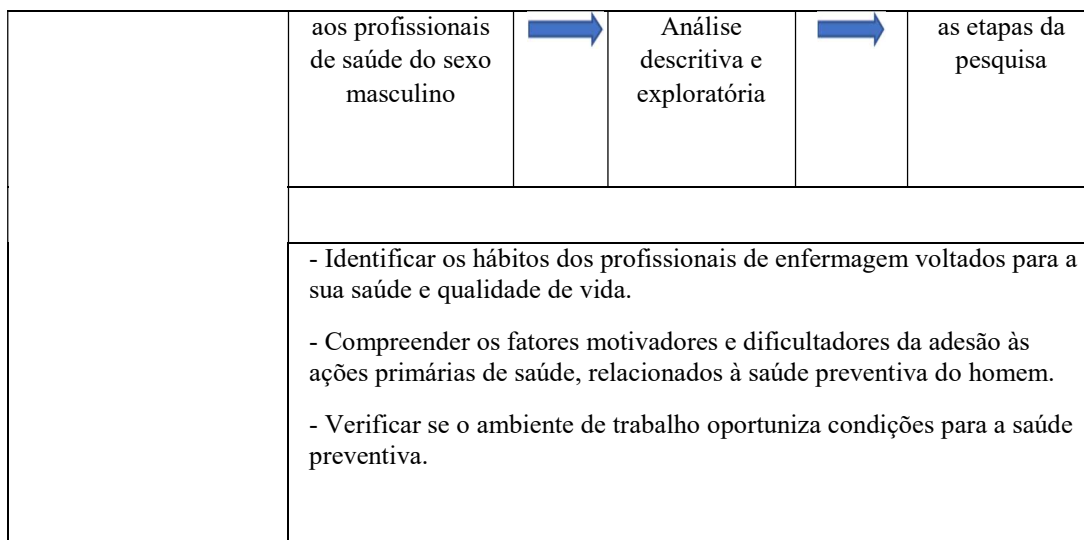
Demo (2011) pontua que se considera como "pesquisa qualitativa" os diferentes significados no campo das pesquisas científicas, utilizando um conjunto de técnicas interpretativas que descrevem e interpretam os componentes dos significados. O objetivo é traduzir e expressar os fenômenos e seus sentidos, reduzindo a distância entre o indicador e indicado, entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação realizada.

Marconi e Lakatos (2017) consideram que os métodos qualitativos são procedimentos semelhantes de interpretação dos fenômenos empregados no cotidiano, possuindo a mesma natureza dos dados que o pesquisador utiliza em sua pesquisa. Em ambos os casos, trata-se de dados simbólicos, que se situam em um contexto, revelando uma realidade parcial. Existem problemas e situações cuja análise pode ser feita sem quantificação de detalhes e sem delimitações precisas de tempo, de lugar, de causas, de procedência dos agentes, e outros detalhes, que embora sejam identificáveis, não representam utilidade na pesquisa.

Diante do exposto para facilitar a compreensão das etapas a serem percorridas na Figura 4 está apresentada a síntese esquemática do presente projeto de dissertação.

Figura 4. Síntese esquemática das etapas de coleta de dados da pesquisa.





Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2024.

4.2 População

A população do estudo foi composta por profissionais de enfermagem do sexo masculino, compreendendo 117 homens que trabalham no Hospital Municipal, porém apenas 57 responderam o formulário inicial. Foram selecionados 20 profissionais com vínculo funcional ativo e que atravessam a fronteira para estudar ou residem no país vizinho. Foram excluídos os profissionais que apenas trabalham e moram em Foz do Iguaçu, em licenças médicas, férias e demais afastamentos legais no momento da pesquisa, totalizando 19 profissionais que participaram da pesquisa.

O número de participantes no presente estudo foi definido pela saturação dos dados. A saturação de dados é definida como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou repetição, estabelecendo ou fechando o tamanho final de uma amostra em estudo (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008).

4.3 Coleta de dados

A coleta de dados descritivos realiza-se com a inserção dos dados coletados via entrevista qualitativa aos profissionais de enfermagem homens do hospital pesquisado, de forma a concretizar os objetivos específicos do estudo ora desenvolvido. Foi utilizado um

roteiro da entrevista semiestruturado (Apêndice A) e seus resultados confrontados com o referencial teórico utilizado.

O tratamento das entrevistas organiza-se em tópicos que se dividem entre o perfil dos profissionais entrevistados, os conceitos de saúde do homem que cada entrevistado apresenta como percepção individual, o tratamento das ações de saúde do homem em cada hospital estudado.

A entrevista é representada por um encontro entre duas ou mais pessoas com o propósito de se obter informações sobre um assunto estabelecido. Para Marconi e Lakatos (2017) as entrevistas variam de acordo com o interesse da pesquisa. Elas podem ser estruturadas, semiestruturada e não estruturadas, por isso devem ser preparadas e direcionadas de acordo com o que se pretende investigar.

A entrevista estruturada compreende a elaboração de um roteiro de perguntas para ser usado em todas as entrevistas. Essa modalidade de entrevista é ideal para quem quer trabalhar com pesquisas mais rápidas sem precisar arriscar a qualidade da coleta de dados, já que o roteiro ajuda a otimizar o tempo total entre perguntas e respostas. A entrevista não estruturada é muito usada para tratar assuntos delicados em busca de feedback, para avaliar serviço ou fazer uma reformulação, neste tipo de entrevista o roteiro de perguntas não é fechado e pode demandar um trabalho maior no processamento de dados. A entrevista semiestruturada é uma mistura dos dois tipos anteriores, pois utiliza um roteiro pré-definido de perguntas, mas prevê momentos de perguntas livres por parte de quem entrevista (Bastos; Santos, 2013).

No caso desta pesquisa, a entrevista tem como finalidade coletar informações sobre a saúde preventiva dos homens que atuam em unidade hospitalar de Foz do Iguaçu. Assim, para realizar a construção do conhecimento empírico torna-se necessário realizar a utilização de várias técnicas de análise e categorização de informações através de um roteiro semiestruturado.

Inicialmente foi realizada a identificação dos participantes, por meio de uma lista dos profissionais fornecida pela instituição, posteriormente o pesquisador fez contato com os participantes de forma direta, por WhatsApp ou e-mail e foi enviado um formulário via Google Forms, com a apresentação da pesquisa e o levantamento dos dados exigidos nos critérios de inclusão e exclusão.

A entrevista aconteceu de forma presencial ou remota síncrona, utilizando a Plataforma Teams. Na entrevista presencial foi utilizado um gravador de voz digital, em que os

depoimentos foram gravados mediante a anuência dos entrevistados, prosseguindo com a disponibilidade de cada sujeito, em local e horário que garantiram a privacidade deles.

No caso da entrevista remota, foi enviado um e-mail, com sugestão de data e horário para a entrevista, após a devolutiva do TCLE e confirmada a data e horário da entrevista, foi enviado um link para a entrevista, a qual foi gravada diretamente na Plataforma Teams, com o consentimento dos participantes.

Os dados foram coletados entre abril e agosto de 2025, utilizando um roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE A), o qual foi elaborado considerando os dados sociodemográficos, referentes a idade, estado civil, função, setor, ocupação e questões que buscam responder aos objetivos propostos, fundamentadas nos eixos da PNAISH e componentes e subcomponentes essenciais para qualidade de vida, conforme Quadro 1 (Pereira, Teixeira, Santos, 2012).

Quadro 1. Apresentação da fundamentação teórica dos objetivos propostos

Objetivos Específicos	Fundamentação teórica
Identificar os hábitos dos profissionais de enfermagem voltados para a sua saúde e qualidade de vida.	Saúde e Qualidade de vida
Compreender os fatores motivadores e possíveis dificultadores para a adesão às ações relacionadas à promoção da saúde e prevenção de agravos do homem no contexto de fronteira.	Saúde do Homem Políticas Nacionais de Atenção Integral à saúde do Homem – PNAISH
Verificar as oportunidades oferecidas em ambiente de trabalho voltadas para a saúde preventiva do homem	Saúde do Homem Atuação dos profissionais e enfermagem na saúde preventiva masculina.

Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2024.

O embasamento teórico das questões de pesquisa elaboradas para o roteiro semiestruturados de entrevistas (APÊNDICE A), estão apresentados a seguir, no Quadro 2, constando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH e o referencial teórico de Qualidade vida (QV), conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2. Relação da Política de saúde do homem e Qualidade de vida com o questionário de pesquisa

REFERENCIAL TEÓRICO	DIMENSÕES REFERENTES	SUBDIMENSÕES	PERGUNTA RELACIONADA
PNAISH	Acesso e acolhimento	Não se aplica	3.2
	Paternidade e cuidado	Não se aplica	3.4
	Saúde sexual e saúde reprodutiva	Não se aplica	
	Prevenção de violências e acidentes	Não se aplica	4.2 – 4.4
	Doenças prevalentes na população masculina	Não se aplica	3.1 – 3.3
QV	<u>Ser</u> – quem é o campo individual	Físico	2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4
		Psicológico	2.6 – 4.3 – 4.4
		Espiritual	
	<u>Pertencer</u> – como se ajusta no contexto	Físico	2.5 – 2.7 – 3.1
		Social	2.1 – 3.1
		comunidade	3.4
	<u>Tornar-se</u> – o que a pessoa faz para alcançar suas expectativas, metas e aspirações	Práticas	2.4 – 4.3
		Lazer	2.1 – 2.6
		Crescimento	
		Progresso pessoal	2.7 – 3.4 – 4.5

Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2024.

4.4 Análise dos dados

Após a coleta de dados, foi realizada a transcrição e leitura minuciosa do material, o qual foi analisado por meio da técnica de Análise de Conteúdo (AC), na modalidade temática, conforme proposta por Minayo (2019), que busca explicar e compreender fenômenos que contemplam as particularidades de cada ser humano grupo ou sociedade, sendo que adquire a profundidade em seus resultados não através de dados quantitativos, mas sim por meio dos significados atribuídos pelos pesquisados, e compreendidos posteriormente pelo pesquisador.

O processo de construção do estudo deu-se em três etapas, a fase exploratória, a fase de campo e a análise do material (MINAYO, 2019). A primeira, consiste na produção do objeto pesquisado e na apropriação dos pressupostos, além da construção do saber teórico acerca da temática, posteriormente foi realizada a fase de coleta de dados ou a fase de campo, utilizando-se de instrumentos elaborados a fim de garantir a profundidade e qualidade das informações

para que por último pudesse ser realizada a análise e interpretação dos dados e informações coletadas.

5. ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, atendendo todos os preceitos éticos, de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa envolvendo seres humanos tendo sido aprovada em 07 de março de 2025, conforme o documento CAAE: 87292125.2.0000.0107 (ANEXO B).

Após uma detalhada explicação sobre o trabalho e da possível participação do voluntário, caso este aceite participar do estudo, foi colhido assinatura de consentimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE (APÊNDICE B). Neste constou toda a parte técnica, de que não incorrerá em nenhum prejuízo para o participante. Foi enfatizado ao profissional que o questionário deveria ser respondido com base em sua própria experiência e, que para que se tivesse validade todas as questões deveriam ser respondidas. Foi garantido o sigilo, o anonimato e o direito de retirar-se da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízos.

Em todas as etapas, foi garantido o anonimato dos participantes. Cada profissional foi identificado com a letra E (enfermeiro), T (técnico de enfermagem), seguido de números ordinais.

Após as entrevistas foram transcritas na íntegra pelo pesquisador que coletou os dados, utilizando o Microsoft Word.

Inicialmente foram conduzidas entrevistas piloto pelo mestrando e supervisionadas pela pesquisadora responsável, que possui experiência em pesquisas qualitativas, visando ajustes e treinamento para a coleta de dados. A inclusão dessas entrevistas piloto nos resultados da pesquisa foi decidida posteriormente. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas integralmente e enviadas aos participantes por e-mail ou WhatsApp para que pudessem ler e revisar a transcrição. Eles tiveram a oportunidade de adicionar, esclarecer ou remover informações da transcrição conforme necessário. Após o envio da transcrição, foi feito contato com os participantes por e-mail e/ou WhatsApp, incluindo o arquivo completo da transcrição. Um prazo de sete dias foi concedido para que revisassem e fornecessem feedback sobre a precisão da transcrição, caso não houvesse resposta dentro desse período, a versão transcrita seria considerada válida pelo pesquisador.

5.1 Riscos

Invasão de privacidade, responder a questões sobre o processo de trabalho do hospitalar e tomar o tempo do sujeito ao responder a entrevista. Para tanto, foram tomadas as seguintes medidas e providências frente aos riscos:

- ❖ Minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões consideradas constrangedoras.
- ❖ Garantir que a coleta de dados fosse realizada pelo próprio pesquisador/mestrando.
- ❖ Estar atento aos sinais verbais e não verbais do desconforto.
- ❖ Garantir que o estudo seria suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou danos à saúde do sujeito participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no TCLE.
- ❖ Garantir que os dados seriam divulgados exclusivamente para fins de pesquisa, sendo assegurado o anonimato dos participantes, ou seja, nenhum dado que pudesse identificar os participantes seria coletado.

5.2 Benefícios

Espera-se com essa pesquisa compreender os aspectos que envolvem a qualidade de vida dos homens e a relação com a política de prevenção da saúde, pois mudanças no atendimento preventivo de saúde do homem pode assegurar a saúde dos trabalhadores beneficiando o sistema de saúde, as relações de trabalho e tantos outros aspectos que envolvem a qualidade de vida masculina.

Dessa forma, o profissional adota a concepção de que, conhecendo a importância da busca de um comportamento preventivo, não por sentir-se ameaçado pelas doenças, mas para prevenir estas enfermidades, garantirá maior expectativa de vida, diminuindo os riscos ocupacionais, prevenindo e diminuindo ausências para tratamento de comorbidades evitáveis, contribuindo com seu estado de saúde, conscientizando o trabalhador do benefício da qualidade de vida na sua saúde e no seu ambiente de trabalho.

Ainda, os dados fornecidos podem subsidiar gestores, profissionais, ou controle social, na tomada de decisão, monitoramento e implementação de melhorias de programas e atenção à saúde do homem, além de fornecer parâmetros específicos das regiões de fronteira e assim, colaborar nas diretrizes e aplicação das políticas públicas voltadas a essas localidades.

6. RESULTADOS

Participaram da pesquisa 19 profissionais, sendo 11 técnicos de enfermagem e 08 enfermeiros, todos são brasileiros e realizam a migração pendular diariamente na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Em relação ao país de residência, 17 profissionais de saúde manifestaram morar no Brasil e 02 possuem domicílio no Paraguai, conforme demonstrado nas características sociodemográfica, apresentada no Quadro 3.

Quadro 3 – Características sociodemográficas dos profissionais de enfermagem participantes do estudo, Foz do Iguaçu 2024.

Variáveis	N = 19 (100%)
Faixa Etária	
Menos de 30 anos	N - 01 (5%)
De 30 a 39 anos	N - 07 (37%)
De 40 a 49 anos	N - 08 (42%)
Mais de 50 anos	N - 03 (16%)
Estado Civil *	
Solteiro (a)	N - 03 (16%)
Casado (a) / União Estável / União Consensual	N - 14 (74%)
Divorciado (a) / Separado (a)	N - 02 (10%)
Grau de Escolaridade *	
Ensino Superior Incompleto	N - 08 (42%)
Ensino Superior Completo	N - 05 (26%)
Pós-graduação (Mestrado, Doutorado, Especialização, etc.)	N - 06 (32%)
Moradia por país	
Paraguai	N - 02 (10%)
Brasil	N - 17 (90%)
Função	
Enfermeiro	N - 07 (37%)
Técnico de enfermagem	N - 12 (63%)
Setor de Atuação	
Psiquiatria	N - 04 (21%)
UTI	N - 03 (16%)
Clínica Cirúrgica	N - 01 (5%)
Clínica Médica	N - 04 (21%)
Ortopedia	N - 02 (11%)
Pronto Socorro	N - 04 (21%)
Transporte	N - 01 (5%)
Vínculo Empregatício	
Estatutário	N - 05 (26%)
CLT	N - 14 (74%)

Formação	
Curso Técnico de enfermagem	N – 08 (42%)
Graduação em enfermagem	N – 05 (26%)
Especialização em enfermagem	N – 06 (32%)
Possui mais de um emprego	
Atua em mais de um vínculo empregatício	N – 06 (31%)
Trabalha somente no Hospital Municipal	N – 13 (69%)
Profissionais que estudam	
É estudante de medicina	N – 18 (95%)
Não estuda	N – 01 (5%)

Fonte: Autoria Própria, 2025

Cabe lembrar que as cidades de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad Del Este, no Paraguai, são separadas pelo Rio Paraná e têm como ligação a Ponte da Amizade, o que permite o trânsito diário e a mobilidade pendular realizada também por meio de transporte público coletivo. Essa proximidade e a instalação de várias universidades internacionais de medicina na fronteira com o Brasil, impulsionaram este tipo de migração, pois não é raro encontrar estudantes de medicina que estudam no Paraguai e residem em Foz do Iguaçu, como também é comum, estudantes residirem no Paraguai e trabalharem no Brasil, da mesma forma acontece em outros segmentos sociais em que trabalhadores de outras áreas residem num país e trabalham no outro (Webber, 2024). Esta é uma característica da migração pendular, mas não deixa de ser um fator que traz apreensão, cansaço, insegurança e outros aspectos que vulnerabilizam os moradores da fronteira. Outro fator importante a ser considerado que essa é uma situação que não está prevista nas políticas públicas de cuidado da saúde do homem (Zaslavsky; Goulart, 2017)

Em relação a percepção dos profissionais sobre as práticas e as oportunidades para promoção da saúde e prevenção de agravos, a análise dos dados possibilitou a construção de cinco categorias temáticas e quinze subcategorias que estão correlacionadas com o referencial teórico e alcançam aos objetivos propostos, conforme apresentado no Quadro 4.

Quadro 4. Apresentação das categorias e subcategorias temáticas e sua relação com o referencial teórico

Categoria Temática	Subcategorias	Relação com Referencial Teórico
Rotina intensa e Desgaste físico e mental	Sono insuficiente; Sobrecarga laboral; Ausência de lazer	Hábitos e práticas; Qualidade de Vida (SER)

Desafios da saúde preventiva em contexto de fronteira Brasil-Paraguai	Percepção dos sistemas de saúde; Acesso e acolhimento transfronteiriço; Impacto cultural e econômico;	PNAISH – Acesso e acolhimento; Saúde Pública – determinantes sociais e barreiras geopolíticas
Prevenção negligenciada	Baixa adesão, busca tardia	PNAISH – Doenças prevalentes
Barreiras culturais e preconceito masculino	Vergonha; tabu sobre exame preventivo	PNAISH – Saúde sexual e reprodutiva
Percepção sobre a importância da vida saudável	Hábitos físicos; Fatores emocionais e sociais; Percepção sobre a importância da vida saudável	Qualidade de Vida (SER, PERTENCER, TORNAR-SE); Relevância para adesão às práticas preventivas

Fonte: Autoria Própria

Na sequência, serão apresentadas de forma detalhada as categorias e subcategorias temáticas indicadas no Quadro 3, dando continuidade à exposição dos resultados por meio das declarações prestadas pelos enfermeiros e técnicos durante a entrevista.

a. Categoria Temática: Rotina intensa e Desgaste físico e mental

Nesta categoria os participantes relatam que vivenciam uma rotina intensa, para conciliar o trabalho, estudos e convivência familiar, como pode ser observado nas subcategorias a seguir:

Subcategoria - **Sono insuficiente**: A rotina intensa foi apontada como fator que interfere na qualidade do sono, como pode ser verificado nas falas abaixo.

“Durmo pouco, mas não deixo de fazer meus exames. ” (T.1)

“...em casa, você dorme lá uma hora, acorda, vai dormir três horas da manhã de novo. (E.1)

“Tem dia que durmo uns 4 a 5 horas. Tem dia que é só uma hora durante a noite [...] Isso é porque às vezes tenho plantão noturno”. (E.2)

A maioria dos relatos em relação ao sono demonstram que os profissionais descansam pouco, isso se deve ao fato de conciliar o trabalho no hospital municipal com outras atividades, a maioria dos entrevistados estuda medicina no Paraguai.

Subcategoria - **Sobrecarga laboral**: Essa subcategoria evidencia que o setor de atuação dos profissionais exerce influência significativa sobre essa condição, especialmente em função da complexidade das atividades desempenhadas e da exigência de escalas noturnas. Esses

fatores contribuem para intensificar a carga de trabalho, impactando diretamente a rotina e o bem-estar dos trabalhadores, como pode ser evidenciado nos relatos a seguir.

“É difícil manter vida saudável na UTI, muito barulho e desgaste.” (E. 7)

“Um dia, estou no plantão, outro dia estou no internato quando eu consigo trocar o meu plantão aqui, trabalhar final de semana vou mais para o Paraguai durante a semana. [...] No internato, todos os dias, salvo exceções, e dependendo do preceptor, ele pode ou não liberar com a possibilidade de você é pagar as horas em outro momento”. (T.3)

“Não tem horário, não tem horário. É como eu posso te explicar, é, dorme a hora que dá, estuda na hora que dá, vai pra faculdade. Na hora que dá, come na hora que dá é sempre assim, sabe? Infelizmente, o meu horário de Descanso é assim, a hora que dá”. (T.5)

As afirmações demonstram um nível de cansaço e sobrecarga que interfere diretamente na saúde física e mental dos profissionais.

Subcategoria – Tempo escasso para lazer: Na subcategoria que demonstra ausência de lazer encontram-se as informações sobre a escassez de tempo para o lazer.

“Às vezes quando não tem aula, eu saio de plantão, já passo na academia, já malho e depois vou para casa” (E.4)

“Antes eu fazia triatlo, maratona, jogava. Mas agora com a faculdade não dá, ia correr uma maratona, mas não pude treinar, não fui”. (E.5)

As declarações dos enfermeiros sobre lazer são gerais entre os profissionais, há um grande envolvimento para conciliar o trabalho e os estudos, o que dificulta a muitos até pensar em lazer.

b. Categoria - Desafios da saúde preventiva em contexto de fronteira Brasil-Paraguai:

Nas entrevistas ficou evidente que o autocuidado de saúde está vinculado à migração pendular, à necessidade de dedicação exclusiva aos estudos somada à necessidade de trabalhar para manter o estudo e a subsistência na cidade. Morar no Paraguai foi percebido como uma necessidade para os estudantes brasileiros, pois precisam evitar perder tempo nas filas que se formam no trânsito carregado da fronteira que convive com turismo de compras e ambiente de exportação, entretanto, trabalhar no Brasil significa manter vínculo empregatício e proteção previdenciária, isso leva muitos profissionais a enfrentar jornadas exaustivas.

Subcategoria - Percepção dos sistemas de saúde: Nessa subcategoria os profissionais manifestam a sua percepção sobre os sistemas de saúde do Brasil e do Paraguai.

“Eu vejo que o atendimento lá (Paraguai), em relação aqui (Brasil), que fica um pouco mais a desejar. Em relação aqui, eu acho que aqui o cuidado já é mais intensivo[...] no hospital que eu faço medicina, o paciente já tem dinheiro, mas se precisar fazer a medicação, o paciente tem que comprar na farmácia. Se ele for fazer um procedimento cirúrgico, tem que comprar todo procedimento cirúrgico na farmácia: a luva, a gás, o fio de nylon, o anestésico, o soro, os cremes, a toalha, tudo, todo material tem que comprar”. (E.6).

“Então, não sei se lá funciona também. Mas, na faculdade, tem algumas campanhas relacionadas à saúde do homem. Faz algumas campanhas lá. Mas é dentro da faculdade. Você percebe lá, o acesso à saúde lá, tem que pagar. A gente vem pra cá, lá tem que pagar”. (E.7)

“Então, assim, no Paraguai, você vê que eles não têm uma cultura de cuidar da saúde. Claro, tem pessoas que cuidam, quem tem um acesso, um patamar de vida. Um pouco melhor, eles se cuidam, se dão saúde. Mas a grande maioria aqui no Paraguai, eu vejo que quem é pobre é pobre de verdade”. (T. 9)

“Lá é medicina de guerra, aqui temos o SUS. (E.4)”

De acordo com as falas no Paraguai não há um Sistema Único de Saúde (SUS) ou equivalente, existem locais que atendem a saúde regional, mas o atendimento é precário, a maioria da população precisa responder economicamente pelos tratamentos.

Subcategoria - **Acesso e acolhimento transfronteiriço:** As falas demonstram que o fato da saúde, no Paraguai, possuir um caráter privado, portanto, só quem dispõe de recursos financeiros tem acesso a tratamentos, motiva o deslocamento de muitos moradores paraguaios a cruzarem a fronteira do Brasil, em busca de assistência, especialmente, tratamento oncológico, atendimentos de urgência e emergência, cirurgias e cuidados que exigem uso de tecnologias e que são mantidos pelo SUS nos serviços brasileiros. Muitos moradores do Paraguai são brasileiros que migraram em busca de trabalho, de terras e para estudar. Neste aspecto, quem busca atendimento nas unidades básicas de saúde brasileiras na região de fronteira, necessita além do acesso à saúde, busca acolhimento para recuperar a saúde.

“No Paraguai, se um brasileiro se machuca, tem que pagar o deslocamento, né? Se cair lá, né? Se machucar lá, tem que pagar o deslocamento. E eles procuram vir mais ser atendidos aqui (Brasil). O pessoal lá vem pra cá sempre. Por causa do tipo de atendimento que fazem aqui também, aqui é mais acessível. Você chega no pronto-socorro, tem que ter documento. Tem um atendimento lá (Paraguai), o pessoal fala que o atendimento é ‘suposto’, né? Se não tem nome, tem nada. Ai você coloca o ‘suposto’ e está com o nome que você falou” (T.6).

“A saúde lá (Paraguai) é precária. É gratuito sim, você tem acesso. Mas se você quebrar um fêmur e quiser fazer uma cirurgia, você tem que comprar todo o material da cirurgia[...] Eles vão fazer pra ti gratuitamente a cirurgia, mas você precisa comprar” (E.8)

Subcategoria - **Impacto cultural e econômico:** Em relação à cultura do autocuidado, os profissionais de saúde informaram que no Paraguai se trata de uma questão cultural negar a necessidade de fazer exames preventivos.

“O pessoal procura mais, atravessa a fronteira, procura mais atendimento de saúde aqui (no Hospital Municipal) ”. (E.6)

“Aqui no Brasil você percebe que os homens também não procuram atendimento, não, também é cultura. Sempre do outro lado a gente não procura médico. É no limite também” (E.8)

“Então eu vejo que a questão de saúde do homem é muito relacionada a isso. Existe sim, tem carência de insumos no Paraguai, tem carência de... Às vezes de profissionais, existe sim esse grande problema. No entanto, também tem suporte para uma questão básica de saúde” (T.10)

De acordo com as informações obtidas, percebe-se que é uma questão específica da população masculina, negligenciar a prevenção à saúde, mas também ocorre a ausência de atendimento especializado, que leva a buscar, quando doente, a ajuda necessária onde houver especialista.

c. Categoria - Prevenção negligenciada: A negligência masculina em relação aos cuidados de saúde preventiva é declarada por vários profissionais.

Subcategoria - **Baixa adesão:** Em relação à adesão dos homens, principalmente nas campanhas de conscientização de busca pela prevenção à saúde do homem os profissionais de saúde reconhecem que se dedicam a uma rotina intensa e negligenciam os seus próprios cuidados.

“Os homens só procuram quando estão quase morrendo, tinha que começar na infância. ” (T.10)

“Deveríamos fazer um check-up por ano, mas só faço quando o trabalho pede. ”(T.8)

“Nunca fiz exame preventivo, mas esse ano vou fazer porque fiquei preocupado. ”(T.5)

Subcategoria: **Busca tardia** - As declarações dos entrevistados sobre a busca tardia para os cuidados de saúde do homem, reforçam que só há procura quando já está com a saúde comprometida.

“Homem só procura médico quando já está mal, deveria ter check-up anual. ”(T.7)

“No Paraguai não tem prevenção, os homens só vão quando não tem jeito” (E.8)

“Deveríamos fazer um check-up por ano, mas só faço quando o trabalho pede” (T.8)

d. Categoria: Barreiras culturais e preconceito masculino: Os relatos demonstram a influência de uma cultura patriarcal, onde os homens são fortes, não reclamam de dor, não adoecem, não demonstram fraqueza é uma das principais causas dos homens buscarem a saúde preventiva quando já não há mais o que prevenir.

Subcategoria- **Vergonha:** considerar vergonha a realização de um exame é uma situação, no mínimo, inusitada por serem profissionais de saúde e demonstra pouco conhecimento de si mesmo de suas condições de saúde.

“Antigamente, eu não sei como está hoje a saúde do homem, porque aqui no Pronto Socorro a gente fala pouco disso, né? Até porque aqui a gente não trabalha com promoção e prevenção, a gente trabalha com paciente instável. Mas na minha época eles faziam muito assim, tinha muito homem que tinha, ainda aquela vergonha... do toque, do exame do proctologista, mas hoje não sei como é, mas hoje em dia muita gente falava que podia fazer no sangue, né? ” (E.8)

Depende da idade também, né, porque normalmente o homem não tem o hábito de fazer exame de rotina, mas eu acho que pelo menos uma vez no ano você tem que fazer um check-up geral, não ter vergonha de procurar o atendimento” (T.8)

“O toque retal é o mais importante, mas o homem tem preconceito. ”(E.6)

Subcategoria - **Tabu sobre exame preventivo:** Existe preconceito dos homens em relação à realização de exames por estar relacionado à vulnerabilidade, o que não aceito na cultura masculina.

“Apesar de que, nem aqui no Brasil, os homens, normalmente, tendem a se cuidar menos, né? É muito difícil você ver um cara que faz exame periódico, que, sei lá, chega a partir de X anos, vai ao urologista. É muito difícil, porque existe um tabu, né? De qualquer forma, em relação à saúde do homem, existe esse tabu, assim”. (T.7)

“O toque retal é o mais importante, mas o homem tem preconceito. ”(E.6)

e. Categoria - Percepção sobre a importância da vida saudável: Os entrevistados conhecem a importância de buscar a qualidade de vida, mas as condições do trabalho e necessidades relacionadas à vida de estudantes comprometem essa busca.

Subcategoria - **Hábitos físicos:** Os hábitos físicos foram manifestados como as atividades que contribuem para melhorar a qualidade de vida como academias, caminhadas, natação, alimentação saudável, não ter vícios.

“Faço academia sempre, porque meu pai tem hipertensão e quero evitar. ” (E.2)

“Eu caminho bastante, mas fumo... e lá no Paraguai não tem campanha nenhuma. ”(T.4)

“Vida saudável hoje envolve dinheiro, sem isso não dá. ”(T.9)

A percepção de vida saudável está vinculada ao trabalho realizado, à moradia e estudo no Paraguai, entretanto, quem trabalha cuidando de doentes, precisa se preocupar com a saúde e bem-estar, pois o sujeito necessita estar bem para cuidar dos outros.

Subcategoria - **Fatores emocionais e sociais:** Os fatores emocionais e sociais que motivam os trabalhadores masculinos da saúde, para a maioria dos entrevistados é a formatura em Medicina, a realização do sonho que, ao mesmo tempo que motiva contribui para que a qualidade de vida esteja comprometida, no entanto, eles não podem protelar a saúde preventiva, pois correm o risco de adoecer e não realizar o sonho.

“Acho que é realmente ficar mais tranquilo, né? Não leva trabalho para casa. Tudo que está aqui, fica aqui e a gente não leva trabalho para casa. Fazer aquela rotina normal mesmo, viver e não deixar nada acumulado” (T.1)

“ Depois que o curso de medicina chegar ao final, conseguirei dar uma melhoradinha, mas pelo que eu vejo, as sequelas ficam, porque parece que depois que você coloca seu corpo a um extremo, por exemplo, tem 15 dias de prova direto, uma atrás da outra, e você tem que estudar todas as madrugadas esses 15 dias. E aí você gera estresse psicológico ali que depois eu sinto que não recupera, dependendo da quantidade de vezes e intensidade que você se expôs a isso, né? (E.3)

Os profissionais entrevistados têm percepção de qualidade de vida, mas o sistema que envolve a sua capacidade física, econômica e social para obter a formação em medicina, indica que estes profissionais levarão um bom tempo para recuperar o desgaste físico, emocional e social desenvolvido, principalmente, pela necessidade de obter o direito de exercer a medicina no Brasil após a formação no exterior.

7. DISCUSSÃO

A realização da pesquisa com 19 profissionais de enfermagem do Hospital Municipal da cidade de Foz do Iguaçu na fronteira com o Paraguai possibilitou compreender a percepção desses profissionais sobre as práticas e as oportunidades para promoção da saúde e prevenção de agravos.

A discussão dos resultados foi organizada apresentando inicialmente os dados sociodemográficos seguido dos comentários dos resultados de cada categoria analisada.

O perfil sociodemográfico dos participantes, releva que a maioria são técnicos de enfermagem, todos possuem nacionalidade brasileira, grande parte com idade entre 30 a 49 anos e, em sua maioria casados. Todos os entrevistados possuem formação específica para o cargo e função que ocupam e, somente um enfermeiro não se declarou estudante de medicina no Paraguai, o que justifica a mobilidade pendular, pois dois enfermeiros residem no Paraguai e trabalham no Brasil e 17 profissionais trabalham e residem no Brasil e estudam no Paraguai.

Estudo realizado por Rizatti et al., em 2018, também aponta que o perfil de profissionais que buscam a transição de carreira são pessoas na fase adulta, casados que buscam se estabelecer numa nova carreira utilizando uma base de conhecimentos já construída anteriormente, o que se encaixa perfeitamente na mudança de carreira dos enfermeiros que estudam medicina, compreende-se que eles buscam realização pessoal, mas também não desejam deixar de cuidar da saúde e de conhecer melhor os cuidados de saúde que podem restabelecer as pessoas.

Fernandes et al. (2025) pontua que os indivíduos buscam um renascimento psicológico na meia idade assim a busca por se tornar uma pessoa inteira canalizando as energias para ter uma profissão, família, condição econômica que permita concretizar os sonhos e desejos, entretanto direcionar e adaptar as energias para buscar essa realização pode ser desgastante e não levar à autorrealização.

A necessidade de manter economicamente a formação é que faz com que o cada entrevistado permaneça atuando no hospital, mesmo levando uma sobrecarga de trabalho e estudo, que contribuir para o adoecimento. A manutenção do vínculo empregatício, mesmo os que atuam como contratados, é uma segurança de manutenção da autorrealização.

O vínculo empregatício com a instituição foi declarado que 05 profissionais são estatutários e 14 são contratados. Ocorre que, por se tratar de uma instituição pública, como é

o caso do Hospital Municipal em estudo, duas realidades distintas estão relacionadas à estabilidade ocupacional: os profissionais concursados e com estabilidade garantindo maior permanência na mesma instituição e, profissionais com contratos em regime da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, que acabam sendo menos permanentes no emprego. A rotatividade de profissionais sobrecarrega a equipe que permanece, gera instabilidade, compromete a qualidade e a continuidade do cuidado (Mattos, 2004). Ao indagar sobre o vínculo dos profissionais com a instituição foi esclarecido que há profissionais concursados que são efetivos do quadro da instituição, mas a maioria é profissional contratado pelo regime de CLT¹.

A formação dos profissionais é importante para o desempenho de cada função, assim 08 profissionais possuem apenas curso técnico de enfermagem e atuam nas funções auxiliares de enfermagem, 05 profissionais são graduados em enfermagem e 06 enfermeiros possuem especialização em nível de pós-graduação. Entre estes profissionais 13 atuam somente no Hospital municipal e 06 profissionais declararam possuir mais de um vínculo empregatício, indicando que leva uma sobrecarga de trabalho, além de ser estudante, pois somente 01 enfermeiro que reside no Paraguai declarou não ser estudante e os outros 18 profissionais são estudantes de medicina no Paraguai.

Os resultados evidenciam que, no geral, os profissionais possuem uma sobrecarga de atividades, tendo que conciliar trabalho e estudo, com atuação em setores complexos como Pronto Socorro e Clínica médica, UTI, psiquiatria, com vínculo CLT, o que não garante a estabilidade e acaba gerando vulnerabilidade econômica, com a família e com os estudos, o que justifica a procura por exercer outros vínculos além do trabalho no hospital. A maioria destes profissionais realizam carga horária de trabalho de 12 x 36 horas, o que oportuniza a disponibilidade para o estudo.

Analisando a categoria que indica a ocorrência de desgastes físicos e rotina intensa, percebe-se que os profissionais entrevistados descrevem essa rotina intensa, que resulta em desgaste físico e mental e repercute em sono insuficiente, intensificado por sobrecarga laboral e implica na ausência de lazer.

O desgaste físico e mental em profissionais que realizam migração pendular, também foi apontado nos estudos de Zaslavsky; Goulart, (2017), Webber (2017) e Santos-Melo et al.,

¹ A CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, é o principal conjunto de normas que rege as relações de trabalho no Brasil, criada em 1943 para organizar direitos e deveres de empregados e empregadores, como jornada de trabalho, férias, 13º salário, FGTS, e seguro-desemprego, formalizando o trabalho com carteira assinada e garantindo proteção ao trabalhador (Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 15.01.2026)

(2024) que relacionam os aspectos ligados aos investimentos públicos no atendimento dos profissionais de saúde nas áreas de fronteira como um direito universal e integral, que necessita ser admitido no plano político e ético, uma vez que a insuficiência de recursos contribui pouco para o custeio de atendimento nas regiões de fronteira.

Brito et al., (2025) pontua que o serviço de enfermagem representa a metade das atividades de cuidados no ramo da saúde no Brasil, com a expressiva quantidade de colaboradores que ultrapassa dois milhões de trabalhadores. Porém é uma categoria, exposta a jornadas exaustivas, materiais insuficientes e sobrecarga emocional, desenvolve um papel fundamental de apoio à saúde, convivendo com situações de desgaste físico e mental das pessoas sob seus cuidados. Ao atuar sob pressão e desenvolver rotina de trabalho intensa os enfermeiros são acometidos por distúrbios emocionais como: estresse, ansiedade e a Síndrome de Burnout, decorrente de privação de sono e acúmulo de trabalho em turnos seguidos durante muitas horas. A pandemia de COVID-19 e as sucessivas contaminações dessa doença mesmo após a vacinação, pois a doença existe e é comum internamentos de pessoas com quadros graves, isso intensificou o cenário caótico, com aumento da carga de trabalho, redução de equipes, medo de ser contaminado e contaminar outras pessoas de sua convivência, além da desvalorização profissional.

Durante a entrevista, enfermeiros e técnicos de enfermagem declararam que existem elementos que influenciam na adesão para a realização de prevenção a doenças, mas que, sem dúvida, a vida na fronteira influi muito na decisão dos cuidados preventivos de saúde. Entre estes motivadores os entrevistados descreveram a rotina de trabalho e de estudo muito intensa, baixa qualidade do sono, jornada dupla de trabalho, pouco tempo para as refeições, além de alimentação irregular e de baixa qualidade nutricional. Por desenvolver uma rotina desgastante, pouco sono e lazer, estes homens evitam exames de prevenção e alguns relataram histórico familiar de hipertensão.

Todos esses agravantes das ações de enfermagem fazem do trabalho uma sequência de fatores que distancia o profissional de sua própria qualidade de vida, conduzindo os profissionais ao desgaste físico e psíquico.

Silva (2000) citado por Marcitelli (2015) ao refletir sobre a qualidade vida como necessária a quem atua em cuidados de saúde admite que o trabalho, mesmo possibilitando crescimento, transformações, reconhecimento e independência pessoal e profissional, também pode ser causa de problemas como insatisfação, desinteresse, apatia e irritação, que trazem consequências negativas para a saúde mental e contribuir para que ocorram doenças ocupacionais, relacionadas às características e

condições inerentes aos tipos de atividades.

A investigação realizada com os profissionais do Hospital municipal buscou compreender como eles percebem a importância da vida saudável e, percebe-se que eles reconhecem a importância disso, mas estão adiando essa busca para depois da formatura em medicina e o reconhecimento de seu diploma para exercer a profissão no Brasil.

Poucos profissionais buscam alimentação nutritiva que lhes possam garantir melhor qualidade de vida, praticam exercícios físicos e realizam exames preventivos que possam promover tratamento adequado antes que qualquer morbidade possa cercear a saúde destes homens (Arruda et al., 2017). A afirmação é confirmada pelas declarações sobre a jornada de trabalho e falta de tempo para uma alimentação adequada.

Alguns enfermeiros e técnicos relataram praticar caminhadas ou frequentar academia, mas mesmo assim, consideram insuficiente para melhorar a qualidade de vida porque não realizam os exames preventivos e carregam uma rotina de trabalho excessivo. Os profissionais entrevistados declararam que encontram dificuldade em manter o lazer, e sabem que precisam modificar a sua realidade realizando exercícios físicos, alguns praticam caminhadas como prevenção a doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão, reconhecendo uma condição de hereditariedade familiar para esta condição.

Para Dias et al., (2021) a prática de atividade física é importante aliada ao fator de promoção à saúde e os seus benefícios estão diretamente relacionados à diminuição do surgimento de doenças crônicas e à redução do risco de morte por doenças cardiovasculares. Entretanto, a busca pela facilidade, a praticidade no cotidiano e a falta de tempo disponível fazem com que o exercício físico regular fique em segundo plano.

Entre os entrevistados desta pesquisa percebe-se que há a percepção sobre a importância da vida saudável, que relataram a importância dada aos hábitos físicos, como lidam com os fatores emocionais e sociais, o relacionamento familiar, demonstrando considerar a importância da vida saudável. A identificação dos hábitos que levam os profissionais aos cuidados de saúde em busca de melhoria na qualidade de vida é percebida e declarada pelos participantes da pesquisa pela realização de exames preventivos, exames periódicos, prática de exercícios físicos, controle alimentar em busca de categorizar e tornar rotina uma alimentação saudável para categorizar uma dieta equilibrada, entretanto, mesmo tendo consciência desta importância, vários profissionais declararam-se negligentes em relação aos cuidados preventivos de saúde (Löff et al. 2024).

Eles conhecem a importância da prevenção dentro do seu cotidiano, pois declararam considerar a realização de caminhadas como uma prática saudável, tendo sido declarado por um enfermeiro que realiza caminhadas para prevenir doenças e outro que faz academia para evitar hipertensão, que considera uma característica hereditária.

Para Marcitelli (2015) quando se trata de qualidade de vida no trabalho dos profissionais de saúde é importante compreender que, quem cuida necessita estar bem para poder dispensar o cuidado adequado aos pacientes. Quando o profissional não se encontra seguro em sua atividade, o risco do tratamento do paciente não certo é expressivo. Durante muito tempo, os profissionais de saúde não se davam conta dos agravos que sofriam na sua própria saúde ao realizar cuidados de modo intensivo, em jornadas duplas de trabalho e, no caso desta pesquisa, em mais de um país.

Souza et al. (2020) ao tratar das vulnerabilidades, concepções e atitudes relacionadas à saúde do homem, expõem que a maioria dos homens relacionam o bem-estar em saúde com alimentação saudável, considerando a nutrição um componente biológico e a alimentação ao social, cultural e sentidos. As práticas de saúde, estão ligadas à prática de exercícios físicos, em busca de vida saudável, relacionando-a também a efeitos psicológicos e hormonais que melhoram a autoestima, a imagem corporal, a socialização, reduz a tensão muscular e a ansiedade, minimiza a insônia e o consumo de medicamentos.

Quando se fala em lazer, a entrevista tornou perceptível que esses profissionais não se dedicam a muitas atividades de lazer, a rotina hospitalar, os plantões e a própria profissão, caracterizam poucas ações de lazer, pois não propiciam tempo e condições físico emocionais para se dedicar a qualquer tipo de distração.

A prevenção negligenciada, caracterizada pela baixa adesão e busca tardia de exames para diagnóstico, em conjunto com as barreiras culturais e o preconceito masculino que são a causa de sentir vergonha e considerar um tabu o exame preventivo se apresentam como categorias muito próximas que não deveriam alcançar profissionais de saúde e, muito menos, estudantes de medicina, mas segundo Carneiro et al. (2019) a adoção da Atenção Primária, ou seja, de atendimento preventivo como porta de entrada dos homens no Sistema Único de Saúde, depende de uma mudança de comportamento da população masculina em relação à própria saúde.

Uma mudança de visão sobre os serviços de saúde como responsável apenas por tratar as doenças adotando uma visão de como é possível realizar exames e prevenir o adoecimento.

Somente por meio do conhecimento a respeito das características sociais, econômicas e culturais dos homens que procuram a atenção à saúde, também é necessário preparar a equipe de saúde e seus gestores, para promover acolhimento, busca ativa e políticas públicas voltadas para essa população (Lemos; Ribeiro; Fernandes, 2017).

Como a pesquisa é direcionada a profissionais de enfermagem que trabalham e estudam, percebe-se que a sobrecarga de trabalho junto com as exigências da vida acadêmica acaba distanciando os homens de suas próprias necessidades, especialmente, de autocuidado.

Dentro das categorias de estudo apresentadas para este estudo os desafios da saúde preventiva em contexto de fronteira Brasil-Paraguai, considerando a percepção dos sistemas de saúde, o acesso e acolhimento transfronteiriço e impacto cultural e econômico, são fatores determinantes da negligência dos enfermeiros e técnicos de enfermagem com a sua própria saúde.

Os profissionais entrevistados realizam migração pendular, ou seja, residem num país e trabalham no outro, essa é uma prática comum, tendo em vista que o atendimento de pacientes do Paraguai no serviço de saúde de Foz do Iguaçu é muito comum. Durante a entrevista, vários profissionais relataram que na realização de atividades assistenciais aos próprios profissionais de saúde não é frequente nem habitual. Entretanto, essa situação é também considerada como uma questão cultural, os homens procuram mais a farmácia e buscam não utilizar o sistema de saúde (Knauth, 2012)

Na interpretação dos entrevistados, existem problemas de ordem prática, o trabalho e a limitação de horários, apresentam-se como fatores que dificultam a busca de recurso de saúde por parte da população masculina, além do medo. Esta é também uma questão cultural, pois muitos consideram que homem não adoece, assim, na visão dos profissionais da saúde, considerando os determinantes de gênero e mais uma expressão do medo do adoecimento por parte dos homens.

Assim, ao analisar as variáveis que determinam se os homens que trabalham no atendimento à saúde e concretizam uma migração pendular, pois residem num país e trabalham em outro, possuem qualidade de vida e, se realizam exames de prevenção que lhes possa garantir melhores condições de saúde por mais tempo, ficou demonstrado que os enfermeiros e técnicos de enfermagem que participaram da pesquisa, muitas vezes, nem se dão conta de que necessitam realizar exames periódicos e de prevenção que possam garantir que sejam tratados adequadamente quando apresentarem algum problema de saúde.

Diante de tudo o que foi mencionado na entrevista, percebe-se que os motivadores que impedem o tratamento de autocuidado e prevenção entre os profissionais de saúde entrevistados ainda é o preconceito que existe entre os trabalhadores de migração pendular na fronteira. Eles vivenciam duas realidades e precisam, urgentemente, buscar tirar proveito dessa diferença cultural, adotando as práticas que possam beneficiá-los, ao despeito do que possa ser fidelidade cultural que impede de melhorar a qualidade de vida, sendo o preconceito em relação ao autocuidado um dos principais impedimentos a ser vencido.

Os profissionais entrevistados residentes no Paraguai que realizam migração pendular, não são impedidos de receberem atendimento nos serviços de saúde no Brasil, mesmo porque ao atuar profissionalmente sem boas condições de saúde, acabam realizando um atendimento de cuidado que pode se tornar precário, caso não haja a prevenção e autocuidado, além de também haver a necessidade buscar a valorização do trabalho desses profissionais.

Todos os entrevistados relataram rotina estressante que leva muitos a automedicação, a negligenciar o atendimento de saúde preventiva, mas nenhum deles relatou existir um programa efetivo de cuidados com os profissionais que trabalham no Hospital Municipal. Assim, é necessário que sejam implementados programas de atendimento à saúde dos trabalhadores com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).

Nos hospitais de fronteira com muitos colaboradores, em que se apresente uma situação de migração pendular entre os enfermeiros e técnicos, como é o caso em estudo, deve-se oportunizar a formação de equipes de enfermagem do trabalho voltada para a promoção da saúde masculina.

A entrevista realizada com os profissionais de saúde (enfermeiros e Técnicos de enfermagem) que atuam no Hospital Municipal, desperta para necessidade de desenvolver a implementação de programas de saúde ocupacional, realizar campanhas de prevenção a doenças específicas voltadas para a busca de melhoria à saúde do homem. Trata-se de se preocupar com a saúde humana dos profissionais, independentemente da localidade onde os mesmos habitam.

O uso de protocolos de enfermagem direcionados à saúde do homem na atenção à saúde ocupacional, esse tipo de abordagem pode se tornar eficiente e garantir que outras discussões sejam empreendidas como a qualidade da saúde ocupacional dos trabalhadores na empresa, a busca de solução para absenteísmo e afastamentos por doenças e a prevenção aos riscos no ambiente de trabalho.

De acordo com Santos et al. (2021) surgem barreiras à inserção do homem nos serviços de saúde, essas também se tornam evidentes entre profissionais de enfermagem, pois ocorre a predominância do machismo, a falta de tempo, o excesso de atendimento, os horários incompatíveis com o período de trabalho. Além disso, o homem é o mantenedor da família, desta forma, o medo de perder o emprego pela sua ausência ao procurar atendimento de saúde e o pensamento de invulnerabilidade são fatores limitantes ao cuidado nessa população. Essas dificuldades provêm de questões culturais, onde predomina o machismo, que reforça a ideia de que o homem é um “ser” que não adoece. Isso se confirma com as declarações dos entrevistados de que na percepção cultural dos paraguaios, ocorre a baixa prevenção devido a cultura, costumes e até mesmo, nos hábitos de se cuidar com tratamentos alternativos realizados com plantas medicinais.

Durante a entrevista, vários profissionais citaram a vulnerabilidade no atendimento dos serviços de saúde do Paraguai como um elemento motivador da negligência e não aceitação da busca pelos cuidados preventivos, isso caracteriza também os aspectos étnicos culturais da população masculina paraguaia, que demonstra preconceito em buscar o atendimento médico por serem homens e na sua concepção homem é forte e não adoece. A masculinidade é também justificativa para adoção de hábitos e costumes que são prejudiciais à saúde.

Dependências também foram citadas, especialmente, o cigarro, mesmo sabendo que isso é prejudicial à saúde. Outro fator citado nas entrevistas que despertam preocupação é a automedicação, pois existe entre profissionais de saúde a facilidade de acesso a medicamentos, mas também é sabido que essa prática é prejudicial, podendo conduzir a abusos de medicamentos na ilusão de que esse profissional vai sentir-se melhor e não precisar de atendimento.

De acordo com Tonelli et al. (2010), o autocuidado, é visto pelos homens como uma representação ligada ao trabalho, pois muitos consideram que não encontrariam no campo organizacional a mesma autorização social para se ausentar de suas atividades laborais. Em relação à alimentação, a maioria das pesquisas demonstra que devido ao pouco tempo para alimentação e às escolhas por alimentos reconhecidos como pouco saudáveis, caracteriza-se deste modo, uma vulnerabilidade dos homens às doenças, principalmente doenças crônicas relacionadas ao fator saúde/doença/cuidado como: hipertensão, diabetes, problemas cardíacos e respiratórios, câncer de próstata, entre outros.

Relacionado as vulnerabilidades relacionadas à saúde dos homens em geral, não se pode deixar de citar numerosos casos de acidentes de trânsito com a população masculina. Acidente no trânsito, é considerada a oitava causa de mortes na população geral, mas segundo Souza et al. (2020), ocorre uma preponderância de pessoas do sexo masculino em função das diferenças comportamentais e de estilo de vida dos homens.

Nenhum participante relatou que já tenha sofrido acidente no trânsito, mas todos eles estão diariamente expostos a este tipo de ocorrência, pois trafegar pela fronteira obriga enfrentar tráfego intenso, impõe a saída antecipada em direção ao trabalho para evitar atrasos.

O relato de um enfermeiro sobre sentir-se cansado e considerar que envelheceu após se tornar pai, indica que há pouco diálogo entre os médicos e pacientes a respeito de sexualidade e de envelhecimento, o profissional não percebeu que o envelhecimento decorre da rotina estressante e não da paternidade. A afetividade com o filho pode melhorar a relação desse profissional com ele mesmo. O envelhecimento está relacionado a não descansar o suficiente, mas não à paternidade em si, essa afetividade pode ser até mesmo uma forma de se renovar e rejuvenescer, tornando-se motivadora do autocuidado.

Nenhum profissional entrevistado citou questões relacionadas à sexualidade, mesmo considerando que esta é uma questão ligada as vulnerabilidades masculinas, as relações sexuais desprotegidas resultam cada vez mais em resultados negativos para os homens. Com isso, o avanço de DST's impulsionou a necessidade de incorporação dos homens nas ações de prevenção e promoção da saúde, devido ao aumento dos casos de transmissão por via heterossexual.

A sexualidade, precisa ser discutida com os homens, mas também está associada a preconceitos. “O assunto sexualidade é tratado a partir do caráter de eventualidade e informalidade, ou ainda abordado sob enfoque de neutralidade, proibições e assexualização humana (Souza et al., 2020, p.943)”. Ao não discutir com profissionais de saúde os problemas relacionados à sexualidade, são reforçados os mitos, as crendices e os tabus que impedem o manejo social do autocuidado masculino.

A educação em saúde com a realização de palestras, distribuição de materiais de leitura informando sobre o importância do autocuidado, a busca de melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo atividades de lazer, prática de exercícios físicos, cuidados com a alimentação, evitar o desenvolvimento de vícios e outras práticas danosas à saúde física e mental, mas é

preciso, principalmente, combater os tabus que afastam os homens do atendimento preventivo nos serviços de saúde e, somente com informações corretas isso é possível.

A realização de um perfil epidemiológico dos profissionais que atuam na unidade hospitalar precisa ser realizada a partir da organização de ações que permitam identificar precocemente doenças características da população masculina, avaliando ocorrências de hipertensão e diabetes, mas também avaliando preventivamente a tendência ao câncer de próstata com orientação a respeito dos exames de PSA e toque retal.

É evidente que são necessárias atividades de prevenção planejando e executando campanhas de vacinação no local de trabalho, mantendo os colaboradores em segurança e em dia com o calendário vacinal. É importante garantir um ambiente de trabalho que inclua o estímulo aos profissionais para que busquem a assistência de prevenção e cuidado, a fim de superar a barreira cultural que indica que homem não precisa de assistência e cuidado.

A afirmação do enfermeiro sobre o envelhecimento com a paternidade instiga para que ações como a abordagem da paternidade e cuidado envolva os homens na atenção e cuidado aos filhos e ao pré-natal do parceiro, sem deixar de incentivar o autocuidado como essencial para a vida do homem.

Para Paula et al. (2022), os homens não buscam por cuidados de saúde, devido à cultura pautada na premissa de sua masculinidade, temor de ser desclassificado em seu gênero por ser identificado como vulnerável ao adoecimento, pois esse é um fenômeno potencializado pela rede de apoio, colegas de trabalho, amigos e até mesmo do imaginário social. As ideias pejorativas a respeito da doença potencializam a cultura da masculinidade, isso contribui para intensificar os índices de morbimortalidade, principalmente as causas sensíveis à atenção primária. É fundamental trabalhar a cultura de masculinidade com profissionais, gestores, homens e entre a população feminina, esse movimento precisa ser inserido nas políticas, direcionadas aos ciclos vitais, em especial as específicas para os grupos vulneráveis (Paula *et al.* 2022, p.09).

Essa afirmação volta-se para a constatação de que a baixa procura masculina por atendimento de saúde está relacionada aos modelos tradicionais de masculinidade, o que desencoraja os homens a buscar os cuidados preventivos no serviço de saúde.

Assim, segundo Mattos (2004) cabe à enfermagem do trabalho, enquanto elemento de gestão da saúde dos trabalhadores atuar para que seja oportunizada a mudança cultural, tornando os serviços de saúde espaços seguros de acesso ao atendimento preventivo e onde se possa discutir e tratar os problemas de saúde específicos dos homens. Diante disso, conclui-se que o ambiente de trabalho precisa oportunizar a prevenção e o autocuidado aos colaboradores

do gênero masculino, executando as políticas públicas de atendimento, mas também estabelecendo um ambiente humanizado capaz de tornar efetivo este autocuidado.

A pesquisa realizada identificou atitudes que levam os homens profissionais da enfermagem na área de fronteira a adoecerem por desenvolver uma rotina estressante de trabalho esquecendo o cuidado à saúde, neste aspecto estes homens se colocam em último plano, mas é importante avaliar a qualidade de vida, para prevenir que doenças possam afastar estes homens do trabalho, é importante considerar que haja atendimento integral à saúde do homem, pois estimular o autocuidado com medidas preventivas no controle das doenças crônicas não transmissíveis e na promoção da saúde, quando se volta para profissionais que atuam no serviço de saúde se transforma também num efeito cascata, ou seja, estes homens vão atuar com mais qualidade no cuidado com os pacientes no hospital onde desenvolvem suas atividades.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo geral compreender a percepção, as práticas e as oportunidades para a promoção da saúde e prevenção de agravos entre profissionais de enfermagem do sexo masculino que atuam em hospital localizado em município de tríplice fronteira. A partir da análise dos dados produzidos nas entrevistas, foi possível alcançar os objetivos propostos e refletir criticamente sobre a saúde do homem no contexto do trabalho em saúde e da mobilidade pendular característica da região de fronteira.

Os resultados evidenciaram que os profissionais de enfermagem do sexo masculino apresentam hábitos de vida marcados por jornadas extensas de trabalho associadas aos estudos no exterior, o que repercute diretamente na adoção limitada de práticas de autocuidado e de promoção da saúde. Observou-se que, embora os participantes possuam conhecimento técnico-científico sobre saúde e prevenção de agravos, esse saber nem sempre se traduz em práticas efetivas voltadas à própria saúde. As falas evidenciaram rotinas exaustivas, marcadas por longas jornadas de trabalho, pela necessidade de atravessar diariamente a fronteira e pela conciliação entre trabalho no Brasil e estudos no Paraguai. Esse contexto impacta diretamente aspectos fundamentais do autocuidado, como alimentação adequada, qualidade do sono, prática regular de atividade física e momentos de lazer.

A alimentação inadequada, a privação de sono, o sedentarismo e a negligência em relação à realização periódica de exames preventivos emergiram como aspectos recorrentes, fortemente relacionados à sobrecarga ocupacional e à falta de tempo. Tais hábitos impactam negativamente a qualidade de vida desses profissionais, reforçando a necessidade de estratégias que favoreçam o equilíbrio entre vida profissional, acadêmica e pessoal.

No que se refere aos fatores motivadores, destacou-se o reconhecimento, ainda que pontual, da importância do autocuidado para a manutenção da capacidade laboral e para o desempenho das atividades assistenciais. A vivência cotidiana com o adoecimento de pacientes também foi apontada como elemento que desperta reflexões sobre a própria saúde.

Entretanto, os dificultadores mostraram-se mais expressivos, sendo fortemente influenciados por aspectos culturais relacionados à masculinidade, pela naturalização do cansaço e da exaustão, pela incompatibilidade de horários com os serviços de saúde e pela dinâmica peculiar da migração pendular na região de fronteira. A percepção de

invulnerabilidade masculina e a priorização das demandas profissionais e acadêmicas em detrimento da saúde pessoal contribuem para a baixa adesão às ações preventivas, mesmo entre trabalhadores da área da saúde.

A adesão dos homens às ações de promoção da saúde e prevenção de agravos mostrou-se fortemente influenciada por fatores culturais, sociais, institucionais e geográficos. Entre os entrevistados, ficou evidente que o autocuidado ainda é atravessado por construções culturais da masculinidade, segundo as quais o homem não demonstra dor, não pede ajuda e não se reconhece como sujeito que necessita de cuidado. O medo de descobrir doenças, aliado à ideia de força e resistência masculina, constitui importante barreira à busca por ações preventivas.

No contexto de fronteira, esses fatores são agravados por questões estruturais, como a sobrecarga dos serviços públicos de saúde, que atendem tanto a população local quanto estrangeira, gerando dificuldades de acesso, escassez de medicamentos, déficit na realização de exames mais complexos e limitações de recursos. Soma-se a isso a presença de barreiras culturais e sociais, como diferenças de idioma, preconceito, racismo e desigualdades no acesso aos sistemas de saúde.

Um aspecto amplamente citado refere-se à cultura paraguaia, percebida pelos entrevistados como marcada por forte preconceito em relação aos exames preventivos, especialmente aqueles relacionados à saúde do homem. A ausência de políticas estruturadas de atenção à saúde masculina no país vizinho, voltadas à prevenção de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e câncer de próstata, contribui para a naturalização do adoecimento tardio. O excesso de trabalho e a responsabilidade de prover o sustento familiar reforçam rotinas que dificultam ainda mais a busca por cuidados preventivos.

Por outro lado, fatores motivadores para a adesão ao autocuidado incluem a valorização do conhecimento sobre saúde, a conscientização acerca da importância da prevenção, o incentivo à busca por atendimento antes do agravamento de problemas de saúde e a capacitação permanente dos profissionais para reconhecerem suas próprias vulnerabilidades. Reconhecer-se como sujeito vulnerável e passível de adoecimento mostrou-se um passo fundamental para a mudança de comportamento em relação à saúde preventiva.

Quanto às oportunidades oferecidas no ambiente de trabalho, os achados indicam que ainda são incipientes as ações institucionais sistematizadas voltadas especificamente à saúde

preventiva do homem. As iniciativas existentes concentram-se, em sua maioria, no cumprimento de exigências legais, como exames admissionais e periódicos, não contemplando ações educativas contínuas ou estratégias de promoção da saúde alinhadas às diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).

Observou-se a ausência de programas estruturados que considerem as especificidades do trabalhador homem em contexto de fronteira, bem como a necessidade de maior articulação entre a gestão hospitalar, os serviços de saúde ocupacional e a atenção primária. A criação de espaços de escuta, flexibilização de horários para acesso aos serviços de saúde e o desenvolvimento de ações educativas no próprio local de trabalho configuram-se como possibilidades para ampliar o cuidado preventivo.

De modo geral, o estudo evidencia que os profissionais de enfermagem do sexo masculino, apesar de atuarem diretamente no cuidado em saúde, encontram dificuldades significativas para cuidar de si, especialmente em um contexto marcado pela sobrecarga de trabalho, mobilidade internacional e construções socioculturais da masculinidade. Os resultados reforçam a importância de fortalecer políticas públicas e ações institucionais que promovam o autocuidado, a prevenção de agravos e a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores.

Este é um assunto pouco abordado, o que torna necessário realizar novos estudos voltados para estabelecer estratégias, técnicas e científicas, que proponham caminhos para fortalecer os serviços de saúde da atenção básica, mobilizando a equipe de enfermagem do trabalho e outros setores que estejam voltados a valorizar e promover a saúde dos profissionais de enfermagem, com campanhas e publicidades, formando grupos masculinos de educação em saúde. Além disso, é necessário promover a capacitação da equipe para atender bem e acolher os clientes, promover melhorias na saúde e tornar a atenção primária mais efetiva e eficaz.

Como limitação desta pesquisa constatou-se que a investigação foi realizada numa região específica de fronteira, entretanto, existem muitas outras fronteiras no Brasil com realidades parecidas e problemas que podem ser avaliados de uma maneira mais aprofundada, por isso sugere-se que outros espaços de fronteira no Brasil sejam pesquisados, empreendendo estudos sobre a percepção dos homens profissionais em saúde sobre as políticas de saúde do homem desenvolvidas e como estas são desenvolvidas e percebidas diante do problema que foi estudado.

Por fim, espera-se que os achados desta pesquisa contribuam para a reflexão e o aprimoramento das práticas de saúde do trabalhador e da saúde do homem, especialmente em regiões de fronteira, incentivando a implementação de estratégias que reconheçam o homem como sujeito de cuidado e promovam condições mais saudáveis de vida e trabalho.

9. REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Ricardo Saraiva; SANTANA, Daniele de Carvalho; SANTANA, Patrícia de Carvalho. A percepção do enfermeiro da estratégia saúde da família sobre a saúde do homem. R. Enferm. Cent. O. Min. 2015 set/dez; 5(3):1844-1854
- AIKES, Solange; RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. A saúde em região de fronteira: o que dizem os documentos do Mercosul e Unasul. Saúde Soc. São Paulo, v.29, n.2, e180196, 2020
- ALBUQUERQUE GA, LEITE MF, BELÉM JM, NUNES JFC, OLIVEIRA MA, ADAMI F. O homem na atenção básica: percepções de enfermeiros sobre as implicações do gênero na saúde. Esc Anna Nery 2014; 18(4):607-614
- ALUM, Julia Noemi Mancuello; BEJARANO, Maria Stella Cabral de. Sistema de Salud de Paraguay. Rev. Salud Pública Parag. 2011; Vol. 1 (1): 13-25. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/965939/13-25.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2024.
- ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- Arruda, G. O., Mathias, T. A. F., & Marcon, S. S. (2017). Prevalência e fatores associados à utilização de serviços públicos de saúde por homens adultos. Ciência & Saúde Coletiva. 22(1), 270-90
- BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 2016. Obra original publicada em 1977.
- BASTOS, L. C.; SANTOS, W. S. A entrevista na pesquisa qualitativa: perspectivas em análise da narrativa e da interação. Rio de Janeiro, RJ: Quartet Faperj, 2013
- BATISTA, N. A; UCHÔA-FIGUEIREDO, L. DA R. (org.). Educação Interprofissional no Brasil: formação e pesquisa. 1. ed. – Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida, 2022.
- BORGES, L. M.; SEIDL, E. M. F. Qualidade de vida em homens idosos Psico-USF, Bragança Paulista, v. 19, n. 3, p. 421-431, set./dez. 2014
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da saúde, 2009.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília: Ministério da saúde, 2012.
- BRASIL. Plano Nacional de Saúde. Brasília –DF: Ministério da saúde, 2010.
- BRASIL. Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Volume 53. N.º 8. Mar. 2022
- CARNEIRO LMR, SANTOS MPA, MACENA RHM, VASCONCELOS TB. Atenção integral à saúde do homem: um desafio na atenção básica. Rev Bras Promoç Saúde, Fortaleza, 29(4): 554-563, out./dez., 2016

CARNEIRO, V. S. M.; ADJUTO, R. N. P.; ALVES, K. A. P. Saúde do homem: identificação e análise dos fatores relacionados à procura, ou não, dos serviços de atenção primária. Arq. Cienc. Saúde UNIPAR, Umuarama, v. 23, n. 1, p. 35-40, jan./abr. 2019.

CAVALCANTI JRD, FERREIRA JA, HENRIQUES AHB, MORAIS GSN, TRIGUEIRO JVS, TORQUATO IMB. Assistência Integral a Saúde do Homem: necessidades, obstáculos e estratégias de enfrentamento. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem 18(4) Out-Dez 2014

CRESWELL, J.W.; CLARK, V.L. Plano. Pesquisa de métodos mistos. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

DEMO, P. Educar pela pesquisa. 9. ed. Campinas: Autores Associados, 2011

FABRIZ, L. A et al. Construcción y validación de una matriz para evaluar la normativa del Sistema Integrado de Salud de las Fronteras. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 29, p. 1-9, 2021. DOI: 10.1590/1518-8345.4141.3433

FEITOSA, T. V. N; MARTINS, W.; JAQUEIRA, M. O Acesso à saúde em região de fronteira: A tríplice fronteira Argentina, Brasil e Paraguai em meio à pandemia do coronavírus. O Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v.4, 2020.

FERNANDES, L. D. de O.; FARIA, M. E. de L.; CORRÊA, N. S. R.; SANTOS, J. A. dos; VILALBA, A. C. de C.; OLIVEIRA, V. S. de. Revisão sistemática de produções científicas brasileiras sobre transição de carreira em adultos na meia idade. **Cuadernos de Educación y Desarrollo - QUALIS A4**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. e7514, 2025. DOI: 10.55905/cuadv17n2-047. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/7514>. Acesso em: 3 fev. 2026.

FERREIRA, C. M, P. G.; MARIANI, M. A. P.; BRATICEVIC, S. I. The multiple borders in the health care provided to foreigners in Corumbá, Brazil. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 24, n. 4, p. 1137-1150, 2015. DOI: 10.1590/S0104-12902015137475

FONTANELLA, B. J. B; RICAS, J; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24(1):17-27, jan, 2008

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018.

GOMES, Romeu. Sexualidade masculina e saúde do homem: proposta para uma discussão. Ciênc. Saúde coletiva v.8 n.3 São Paulo 2007. Disponível em: www.scielo.org.br. Acesso em 16 de jun. 2023

GOMES, Romeu; NASCIMENTO, Elaine Ferreira do. A produção do conhecimento da saúde pública sobre a relação homem-saúde: uma revisão bibliográfica. Cad. Saúde Pública v.22 n.5 Rio de Janeiro maio 2006. Disponível em: www.scielo.org.br. Acesso em 16 de jun. 2022.

GUIARRARA, Paloma. "Migração pendular"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/migracao-pendular.htm>. Acesso em 05 de janeiro de 2025.

INSTITUTO PAPAÍ (2002) – Relações compartilhadas. Cartilha. Apoio: CNB-CUT.

JULIÃO, Gésica Graziela; WEIGELT, Leni Dias. Atenção à saúde do homem em unidades de estratégia de saúde da família. R. Enferm. UFSM 2011 Mai/Ago;1(2):144-152

- KNAUTH, D. R.; COUTO, M.T.; FIGUEIREDO, W. S. A visão dos profissionais sobre a presença e as demandas dos homens nos serviços de saúde: perspectivas para a análise da implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(10):2617-2626, 2012
- MARCITELLI, C.R.A. Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais de Saúde. *UNICIÊNCIAS*, v. 19, n. 2, p. 169-173, Dez. 2011
- MARCONI, M.A; LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2017
- MARTÍNEZ, Virginia Ruiz de Martín Esteban. O acesso dos usuários transfronteiriços paraguaios aos serviços públicos de saúde no Brasil. 2020. 154 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública na Região de Fronteira) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2020.
- MATTOS, Luciano. Práticas e processos em recursos humanos. Curitiba: IBRATE, 2004.
- MENDONÇA, Vítor Silva; ANDRADE, Angela Nobre de. (2010). A Política Nacional de Saúde do Homem: necessidade ou ilusão? *Psicologia Política*, 10(20), 215-226.
- MEZZOMO, Augusto Antonio. Fundamentos da Humanização Hospitalar. Santos SP: Editora da U. Católica de Santos, 2003.
- MINAYO MCS. Pesquisa social: teoria, métodos e criatividade. 28ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2009.
- MONARDO, M.; STALINO, P. Saúde na Fronteira Brasileira: Políticas Públicas e Acesso a Serviços. Espaço Aberto, PPGG - UFRJ, Rio de Janeiro, V. 10, N.1, p. 99-116, 2020
- MOURA, Erly Catarina de; SANTOS, Wallace dos; NEVES, Alice Cristina Medeiros das; GOMES, Romeu; SCHWARZ, Eduardo. Atenção à saúde dos homens no âmbito da Estratégia Saúde da Família. *Ciência & Saúde Coletiva*, 19(2):429-438, 2014
- MOURA, E. C; GOMES, R; PEREIRA, G. M. C. Percepções sobre a saúde dos homens numa perspectiva relacional de gênero. *SciELO Brasil*, 2014.
- OMS - Organização Mundial da Saúde. A importância de promover exames preventivos para homens. Gestão da medicina preventiva. (2020). Disponível em: <https://previva.com.br>. Acesso em 28.08.2023
- OLIVEIRA JA, ARAÚJO IFM, SILVA GTR, SOUSA AR, PEREIRA A. Estratégias e competências do enfermeiro na atenção à saúde do homem: uma revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. 2020
- PAULA CR, LIMA FH, PELAZZA BB, MATOS MA, SOUSA AL, BARBOSA MA. Desafios globais das políticas de saúde voltadas à população masculina: revisão integrativa. *Acta Paul Enferm*. 2022;35: eAPE01587.
- PEREIRA, E.F.; TEIXEIRA, C.S. & SANTOS, A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. *Rev. bras. Educ. Fís. Esporte*, São Paulo, v.26, n.2, p.241-50, abr./jun. 2012
- POLIGNANO, Marcus Vinícius. História das Políticas de Saúde no Brasil: uma pequena revisão (2006). Disponível em: www.scielo.org.br. Acesso em 20 de julho de 2023.

RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 4. ed. São Paulo: 2011.

RIZZATTI, Daniela Bach et al. Transição de carreira em adultos brasileiros: um levantamento da literatura científica. Gerais, Rev. Interinst. Psicol. Belo Horizonte, v. 11, n. 1, p. 153-173, 2018. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202018000100012&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 03 fev. 2026. <https://doi.org/10.36298/gerais2019110112>.

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertação e estudo de caso. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SANTOS-MELO GZ, ANDRADE SR, COELHO JIM, FUZA RL, SILVA AMI, NOGUEIRA VMR, MONTEIRO AX. Atendimento de saúde a residentes fronteiriços: construção de uma realidade a partir de valores éticos. Saúde Debate. RIO DE JANEIRO, V. 48, N. 143, e9301, out-dez 2024

SANTOS RR, MORAIS EJ, SOUSA KH, AMORIM FC, OLIVEIRA AD, ALMEIDA CA. Saúde do homem na atenção básica sob o olhar de profissionais de enfermagem. Enferm Foco. 2021;12(5):887-93.

SANTOS KC, FONSECA DF, OLIVEIRA PP, DUARTE AGS, MELO JMA, SOUZA RS. Men's health care: construction and validation of a tool for nursing consultation. Revista Brasileira de Enfermagem. 2020;73(3)

SANTOS, Priscila Henrique Bueno dos; DAL PRÁ, Keli Regina. A invisibilidade da saúde do homem nos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política Social. Florianópolis-SC: UFSC, 27 a 29 de outubro de 2015

SCHRAIBER, Lília B lima; FIGUEIREDO, Wagner dos Santos; GOMES, Romeu; COUTO, Márcia Thereza; PINHEIRO, Thiago Félix; MACHIN, Rosana; SILVA, Geórgia Sibebe N. da; VALENÇA, Otávio. Necessidades de saúde e masculinidades: atenção primária no cuidado aos homens. Cad. Saúde Pública vol.26 no.5 Rio de Janeiro maio 2010. Disponível em: www.scielo.org.br. Acesso em 22 de julho de 2011.

SEPARAVICH, Marco Antonio; CANESQUI, Ana Maria. Saúde do homem e masculinidades na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: uma revisão bibliográfica. Saúde Soc. São Paulo, v.22, n.2, p.415-428, 2013 423

SILVA, PAS; FURTADO, MS; GUILHON, AB, SOUZA, NVDO; DAVID, HMSL . Saúde do homem na visão do enfermeiro. Esc Anna Nery (impr.)2012 jul -set; 16 (3):561- 568

SOUZA, A.A.; SILVA, M.R.F. Saúde do Homem e seus desafios: medicalização dos corpos com determinante expressivo em idosos hipertensos. Revista Nursing, 2023, 26, 297.

SOUZA, A. R. de; QUEIROZ, A. M.; FLORENCIO, R. M. S.; PORTELA, P. P.; FERNANDES, J. D.; PEREIRA, Álvaro. Homens nos serviços de atenção básica à saúde: repercussões da construção social das masculinidades. Revista Baiana de Enfermagem, [S. l.], v. 30, n. 3, 2016. DOI: 10.18471/rbe.v30i3.16054. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/16054>. Acesso em: 12 set. 2024.

SOUSA MCP, CRUZ JN, ELIAS CMV, GONÇALVES NPC, SOUSA ML, SOUSA PCC. Vulnerabilidades, concepções e atitudes relacionadas à saúde do homem. 2020 jan/dez; 12:939-945. DOI: <http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v12.6478>.

STORINO LP, SOUZA KV, SILVA KL. Necessidades da saúde de homens na atenção básica. Esc Anna Nery (impr.) 2013 out - dez; 17 (4): 638-645

TONELI, M. J. F.; SOUZA, M. G. C.; MULLER, R. C. F. Masculinidades e práticas de saúde: retratos da experiência de pesquisa em Florianópolis/SC. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 973-994, 2010.

VASCONCELOS, M. M. M; Formação de professores: o desafio de integrar estágio com ensino e pesquisa na graduação. R. bras. Est. pedag. Brasília, v. 90, n. 226, p. 609-623, set./dez. 2009.

VERGARA, Sylvia Constant. Projeto e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

WEBBER, Maria Aparecida. Fluxos do saber: migração brasileira para estudo na tríplice fronteira. Trabalho (Mestrado). PPGA – UFPR. Fonte: <https://eventos.ufpr.br/semanarq/semanarq2017/paper/viewFile/1073/406>. Acessado em: 25 de agosto de 2024.

ZASLAVSKY R; GOULART, B.N.G. Migração pendular e atenção à saúde na região de fronteira. Ciência & Saúde Coletiva, 22(12):3981-3986, 2017

APÊNDICES

10. APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

PESQUISA: Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de tríplice fronteira

Nome do Entrevistador:

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOCIODEMOGRÁFICOS:

- 1.1 Data da entrevista:/...../.....
- 1.2 Iniciais Nome:
- 1.3 Nacionalidade: País de residência
- 1.4 Idade:
- 1.5 Estado Civil: 1. () Solteiro 2. () Casado 3. () Viúvo
- 1.6 Função: Enfermeiro () Técnico de Enfermagem () Auxiliar de Enfermagem ()
- 1.7 Setor de atuação:
- 1.8 Ocupa algum cargo: () Não () Sim Qual:.....
- 1.9 Escolaridade: Escolaridade (pode assinalar mais de uma alternativa): Curso técnico () graduação () pós-graduação: () Especialização () mestrado () doutorado () pós-doutorado
- 1.10 Jornada de trabalho diáriahoras.
- 1.11 Possui mais de um vínculo empregatício? () não () sim, em qual área?.....
- 1.12 É estudante? () não () sim, qual curso?..... Qual ano/período está cursando?
- 1.13 Realizada mobilidade pendular para qual país? () Brasil () Paraguai () Argentina
- 1.14 Qual motivo da mobilidade pendular?
- 1.15 Qual a frequência com que realiza a mobilidade pendular? () diariamente () outros.

2 ESTILO DE VIDA, PERCEPÇÕES E CUIDADOS COM A SAÚDE

- 2.1 Referente a esporte e lazer, comente sobre seus hábitos
- 2.2 Descreva sobre sua rotina alimentar e comente seus hábitos diários/periodicidade.
- 2.3 Possui algum hábito pessoal ou vício? (Cigarro, bebida, compulsão por comidas, doces)
Caso afirmativo descreva em que momento iniciou, periodicidade e necessidade de continuidade e outros aspectos que julgar relevante.
- 2.4 Comente como se dá seu período de sono e descanso. Qual sua rotina, descreva seu horário que acorda, que estuda, que trabalha, que vai dormir?

- 2.5 Considerando seus hábitos de deslocamento na fronteira, na sua percepção quais as diferenças no cuidado com a atenção à saúde do homem entre os países?
- 2.6 Comente sobre sua saúde física e mental. Que atividades realiza para relaxar e que julga importante para sua rotina de saúde?
- 2.7 Para você, o que pode ser considerado como “vida saudável”? Como você se percebe nessa condição?

3. PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

- 3.1 Em relação à saúde do homem, qual exame preventivo acha importante realizar periodicamente? Você faz exames preventivos? Quais? Quais você considera importante fazer? Por quê?
- 3.2 Qual serviço de saúde você procura regularmente? Comente sobre seu acesso e atendimento recebido.
- 3.3 Comente sobre possível história pregressa de alguma doença crônica? (Diabetes, Hipertensão, cardiopatia, artrite ou artrose, outras doenças). Você descobriu ser portador destas doenças?
- 3.4 Em relação aos serviços de saúde, o que poderia ser feito para aumentar a procura da medicina preventiva pelos homens? Você acredita que os homens fazem prevenção? Fale-me sobre isso.

4. SAÚDE NO TRABALHO

- 4.1 Na sua percepção como a instituição aborda a prevenção de doenças laborais e aquelas não decorrentes do trabalho? Justifique.
- 4.2 Quais as doenças que podem decorrer da sua atividade? Você acredita que seu trabalho pode levar ao adoecimento? Qual a sua percepção?
- 4.3 Como é possível manter uma vida saudável na sua rotina de trabalho?
- 4.4 No seu setor já foi realizado algum trabalho de prevenção às doenças psicológicas? (Depressão, estresse) Conte-me sobre essa experiência. Você acha necessário? Por quê?
- 4.5 Você considera as relações pessoais no trabalho um motivo que possa afastá-lo do trabalho? Por quê?

APÊNCICE B – TCLE



Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)



Comitê de Ética
em Pesquisa com
Seres Humanos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de tríplice fronteira

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – “CAAE” N°:

Pesquisador para contato: Fabricio Ferreira Delaterra

Telefone: (45) 999295106

Endereço de contato (Institucional): fabricio.delaterra@unioeste.gov.br

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre saúde do homem, a título de mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira, da instituição Unioeste. Os objetivos estabelecidos são de compreender a percepção dos trabalhadores de saúde homens, que atuam em hospital localizado em região de fronteira e estudam em país vizinho, sobre a sua saúde preventiva e têm o propósito de subsidiar gestores, profissionais, ou o controle social, na tomada de decisão, monitoramento e implementação de melhorias de programas e atenção à saúde do homem, além de fornecer parâmetros que considerem as especificidades das regiões de fronteira e assim colaborar nas diretrizes de novas políticas públicas voltadas a essas localidades.

Para que isso ocorra você será submetido a uma entrevista através de um questionário que acontecerá de forma presencial ou remota, utilizando a Plataforma Teams. Na entrevista presencial será utilizado um gravador de voz digital, em que os depoimentos serão gravados, em local e horário que garantam a privacidade.

No caso de optar por entrevista remota, será enviado um e-mail, com sugestão de data e horário para a entrevista. No entanto, a pesquisa poderá causar possível invasão de privacidade, responder a questões sobre o processo de trabalho do hospitalar e tomar o tempo ao responder a entrevista, se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Também você poderá a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo, no entanto, terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem nunca serão associados aos resultados desta pesquisa, exceto quando você desejar. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso.

Este documento que você vai assinar contém 2 páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada no cartório (caso tenha). Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 12h30 as 17h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 – Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira,

você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092 e (45) 99113-1149 – WhatsApp.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento.

Nome do participante da pesquisa:

Assinatura: _____

Eu, _____, declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante _____.

Assinatura do pesquisador

Foz do Iguaçu, _____ de _____ de 2025.

ANEXOS

11. ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

2



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Anexo II Autorização da Instituição Coparticipante

Os pesquisadores Fabricio Ferreira Delaterra e Luciana Aparecida Fabríz estão autorizados por esta instituição Hospital Municipal Padre Germano Laucka realizarem a pesquisa intitulada "Percepção da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de tríplice fronteira", assegurando as normas da Resolução 466/12 e/ou 510/16 – CNS/MS e suas complementares.

Declaramos que a coleta de dados nessa Instituição Coparticipante será iniciada somente após a aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste (CEP – UNIOESTE).

Iélita Santos da Silva
Diretora Presidente - HMPGL
Portaria nº 80344

Iélita Santos da Silva
Diretora Presidente
Fundação Municipal de Saúde

Foz do Iguaçu, 07 de março de 2025.

ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Percepções da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do sexo masculino em hospitais de tríplice fronteira

Pesquisador: LUCIANA APARECIDA FABRIZ

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 87292125.2.0000.0107

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.552.118

Apresentação do Projeto:

Projeto Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus de Foz do Iguaçu. Este estudo investiga a percepção da saúde do homem entre profissionais de enfermagem do gênero masculino que trabalham nos hospitais da tríplice fronteira a fim de compreender a sua percepção, suas práticas e as oportunidades para promoção saúde e para prevenção de agravos de saúde entre os profissionais. O problema de pesquisa busca responder: qual a percepção dos profissionais da enfermagem do sexo masculino, que atuam em hospitais localizado em região de fronteira e realizam a migração pendular, sobre a sua saúde preventiva? A metodologia apresenta-se como um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Participarão da pesquisa profissionais da enfermagem homens, que trabalham em um hospital que realiza atendimentos SUS. A coleta de dados acontecerá entre abril e julho de 2025, por meio de entrevistas presenciais ou remotas, por meio da plataforma Teams, utilizando um roteiro de entrevista semiestruturado, o qual foi elaborado considerando os dados sociodemográficos, referentes a idade, estado civil e questões que buscam responder aos objetivos propostos, fundamentadas nos eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.552.118

(PNAISH) e componentes e subcomponentes essenciais para qualidade de vida. Os dados serão analisados, seguindo as diretrizes da análise de conteúdo, na modalidade temática de Minayo (2019). Espera-se com essa pesquisa compreender os aspectos

que envolvem a qualidade de vida dos homens e a relação com a política de prevenção da saúde, subsidiando gestores, profissionais e o controle social, na tomada de decisão, monitoramento e implementação de melhorias e de ações práticas de voltada à atenção à saúde do homem, além de fornecer parâmetros que considerem as especificidades das regiões de fronteira.

Objetivo da Pesquisa:

Compreender a percepção, as práticas e as oportunidades para promoção da saúde e prevenção de agravos entre profissionais de enfermagem do sexo masculino, que atua em hospital em município de triplíce fronteira

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Invasão de privacidade, responder a questões sobre o processo de trabalho do hospitalar e tomar o tempo do sujeito ao responder a entrevista. Para

tanto, serão tomadas as seguintes medidas e providências frente aos riscos:

¿ Minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões consideradas constrangedoras.

¿ Garantir que a coleta de dados seja realizada pelo próprio pesquisador/mestrando.

¿ Estar atento aos sinais verbais e não verbais do desconforto.

¿ Garantir que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou danos à saúde do sujeito participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no TCLE.

¿ Garantir que os dados serão divulgados exclusivamente para fins de pesquisa, sendo assegurado o anonimato dos participantes, ou seja, nenhum dado que possa identificar os participantes será coletado.

Benefícios:

Espera-se com essa pesquisa compreender os aspectos que envolvem a qualidade de vida dos homens e a relação com a política de prevenção da saúde, pois mudanças no atendimento preventivo de saúde do homem pode assegurar a saúde dos trabalhadores beneficiando o sistema de saúde, as relações de trabalho e tantos outros aspectos que envolvem a qualidade de vida masculina. Dessa forma, o profissional adota a concepção de

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.552.118

que, conhecendo a importância da busca de um comportamento preventivo, não por sentir-se ameaçado pelas doenças, mas para prevenir estas enfermidades, garantirá maior expectativa de vida, diminuindo os riscos ocupacionais, prevenindo e diminuindo ausências para tratamento de comorbidades evitáveis, contribuindo com seu estado de saúde, conscientizando o trabalhador do benefício da qualidade de vida na sua saúde e no

seu ambiente de trabalho. Ainda, os dados fornecidos poderão subsidiar gestores, profissionais, ou o controle social, na tomada de decisão, monitoramento e implementação de melhorias de programas e atenção à saúde do homem, além de fornecer parâmetros que considerem as especificidades das regiões de fronteira e assim, colaborar nas diretrizes e aplicação das políticas públicas voltadas a essas localidades.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

não há.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos anexados.

Recomendações:

não há.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

sem pendências.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2514948.pdf	20/03/2025 09:15:22		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_CEP2025.pdf	20/03/2025 08:50:40	FABRICIO FERREIRA DELATERRA	Aceito
Folha de Rosto	folhaderosto_assinado.pdf	11/03/2025 16:20:28	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Orçamento	Orcamento.pdf	11/03/2025 16:10:45	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Declaração de concordância	pesquisa_autorizacao.pdf	11/03/2025 16:02:23	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_ciencia_e_compromisso.pdf	11/03/2025 15:59:48	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.552.118

Declaração de Pesquisadores	Formulario_de_Pesquisa.pdf	11/03/2025 15:58:46	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_uso_de_dados.pdf	11/03/2025 15:57:35	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_de_intervencao.pdf	11/03/2025 15:55:58	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	11/03/2025 15:52:51	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Solicitação Assinada pelo Pesquisador Responsável	Solicitacao_pesquisa.pdf	11/03/2025 15:52:18	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Dissertacao_Fabricio_Saude_do_Home m.pdf	11/03/2025 15:38:14	LUCIANA APARECIDA FABRIZ	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 07 de Maio de 2025

Assinado por:

**Franciele Foschiera Cambain
(Coordenador(a))**

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br